



Bunga Rampai

KEBIJAKAN, MANAJEMEN DAN SISTEM KESEHATAN

UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

Akbar Suseno • I Made Raka • Arnetty,
Muh. Abdurrouf • Ceria Febiana • Siti Hotna siagian

Editor : Yuliati

BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN, MANAJEMEN, DAN SISTEM KESEHATAN: UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

Penulis:

Ns. Akbar Suseno, M.Kep.

I Made Raka, S.ST., M.Kes.

Drg. Arnetty, M.Kes.

Dr. Muh. Abdurrouf, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ceria Febiana, S.Si., M.KM., MOS.

Ns. Siti Hotna siagian, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Yuliati, SKp., MM., M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Bunga Rampai Kebijakan, Manajemen, dan Sistem Kesehatan: Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Penulis:

Ns. Akbar Suseno, M.Kep.

I Made Raka, S.ST., M.Kes.

Drg. Arnetty, M.Kes.

Dr. Muh. Abdurrouf, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ceria Febiana, S.Si., M.KM., MOS.

Ns. Siti Hotna siagian, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Yuliati, SKp., MM., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-78-3

Cetakan Pertama: Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Buku **Bunga Rampai Kebijakan, Manajemen, dan Sistem Kesehatan: Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia** disusun untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana kebijakan, tata kelola, dan inovasi sistem kesehatan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan. Di tengah tantangan ketimpangan akses, pembiayaan, beban penyakit, serta tuntutan pelayanan yang aman dan berpusat pada pasien, penguatan manajemen dan sistem kesehatan menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, buku ini menghadirkan pembahasan yang menghubungkan kerangka konseptual dengan praktik implementasi, agar pembaca mampu melihat persoalan layanan kesehatan tidak hanya pada level klinis, tetapi juga pada level sistem dan kebijakan.

Materi buku disajikan runtut sesuai daftar isi. **Chapter 1** mengawali dengan analisis sistem kesehatan Indonesia menggunakan kerangka *WHO Health System Building Blocks* untuk memahami kekuatan, celah, dan tantangan pada enam komponen utama sistem. **Chapter 2** membahas kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), transformasi kesehatan, keterkaitannya dengan sistem kesehatan, serta kontribusinya terhadap target SDGs bidang kesehatan tahun 2030. Selanjutnya, **Chapter 3** menguraikan manajemen pelayanan kesehatan primer melalui Puskesmas, pendekatan *family medicine*, dan penguatan PIS-PK sebagai instrumen intervensi keluarga, termasuk aspek sinergi dan keberlanjutan program.

Penguatan mutu dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi fokus bab-bab berikutnya. **Chapter 4** membahas mutu pelayanan dan keselamatan pasien, mencakup konsep dasar, kebijakan dan regulasi di Indonesia, strategi penguatan, serta peran manajemen dan kepemimpinan dalam memastikan mutu layanan. **Chapter 5** mengangkat digitalisasi sistem kesehatan melalui rekam medis elektronik, telehealth, dan *big data health* sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis data, termasuk implikasinya bagi manajemen dan kebijakan. Sebagai penutup, **Chapter 6** membahas inovasi dan kepemimpinan dalam perubahan organisasi kesehatan, termasuk hambatan dalam menjalankan inovasi dan arah penguatan ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi, pengelola layanan, dan pemangku kebijakan sebagai referensi untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 ANALISIS SISTEM KESEHATAN INDONESIA: KERANGKA WHO HEALTH SYSTEM BUILDING BLOCKS.....

1	1
Ns. Akbar Suseno, M.Kep.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Analisis 6 Building Blocks WHO (<i>World Health Organization</i>).....	2
C. Tantangan Sistem Kesehatan.....	10
D. Implementasi Sistem Kesehatan Indonesia	13
E. Referensi.....	16

CHAPTER 2 KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) , TRANSFORMASI KESEHATAN, SISTEM KESEHATAN , DAN TARGET SDGs TAHUN 2030.....

19	19
I Made Raka, S.ST., M.Kes.	19
A. Pendahuluan / Prolog.....	19
B. Konsep dan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	19
C. Transformasi Sistem Kesehatan Nasional	21
D. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan	22
E. Gambaran Umum SDGs.....	22
F. Keterkaitan JKN, Transformasi Kesehatan, dan Target SDGs 2030	22
G. Penutup	23
H. Referensi.....	23

CHAPTER 3 MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER: PUSKESMAS, FAMILY MEDICINE DAN PIS PK

25	25
Drg. Arnetty, M.Kes.....	25
A. Pendahuluan/Prolog	25
B. Pendekatan Pelayanan Kesehatan Primer Masa Depan.....	26
C. Manajemen Puskesmas Dan Tata Kelola Organisasi.....	29
D. Implementasi Family Medicine Di Tingkat Puskesmas.....	30
E. Penguatan PIS-PK sebagai Instrumen Intervensi Keluarga.....	33

F. Sinergi Dan Keberlanjutan Program.....	36
G. Referensi.....	39

CHAPTER 4 PENGUATAN MUTU PELAYANAN DAN KESELAMATAN

PASIENT DALAM FASILITAS KESEHATAN41

Dr. Muh. Abdurrouf, S.Kep., Ns., M.Kep.....	41
A. Pendahuluan.....	41
B. Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan	42
C. Keselamatan Pasien sebagai Pilar Mutu Pelayanan.....	46
D. Kebijakan dan Regulasi Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien di Indonesia.....	48
E. Strategi Penguatan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien.....	51
F. Peran Manajemen dan Kepemimpinan dalam Menjamin Mutu dan Keselamatan Pasien.....	53
G. Tantangan dan Peluang Penguatan Mutu Pelayanan di Masa Depan	55
H. Simpulan.....	57
I. Referensi.....	58
J. Glosarium.....	60

CHAPTER 5 DIGITALISASI SISTEM KESEHATAN: REKAM MEDIS

ELEKTRONIK, TELEHEALTH, DAN BIG DATA HEALTH63

Ceria Febiana, S.Si., M.KM., MOS.	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Konsep dan Ruang Lingkup Digitalisasi Sistem Kesehatan	63
C. Rekam Medis Elektronik	64
D. Telehealth sebagai Model Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh.....	65
E. Big Data Health dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data.....	66
F. Integrasi RME, Telehealth, dan Big Data Health	67
G. Implikasi Digitalisasi Sistem Kesehatan bagi Manajemen dan Kebijakan	67
H. Referensi.....	68

CHAPTER 6 INOVASI DAN KEPEMIMPINAN DALAM PERUBAHAN

ORGANISASI KESEHATAN.....69

Ns. Siti hotna siagian, S.Kep., M.Kep.....	69
A. Pendahuluan/Prolog	69
B. Hambatan dalam menjalankan inovasi dalam organisasi kesehatan.....	73
C. Simpulan.....	74
D. Referensi.....	75

PROFIL PENULIS	77
-----------------------------	-----------

CHAPTER 1

ANALISIS SISTEM KESEHATAN INDONESIA: KERANGKA WHO HEALTH SYSTEM BUILDING BLOCKS

□ Ns. Akbar Suseno, M.Kep. □

A. Pendahuluan

Konsep Analisis Sistem Kesehatan Indonesia (SKI) mengadopsi kerangka 6 *Building Blocks* Sistem kesehatan dari organisasi kesehatan dunia (WHO) berupa layanan kesehatan (*service delivery*), tenaga kesehatan (*health workforce*), informasi kesehatan (*health information*), akses keuangan/pembiayaan (*access to financing/health financing*), obat & teknologi medis (*medicines & technologies*), serta kepemimpinan & tata kelola (*leadership & governance*). Analisis ini membandingkan komponen sistem kesehatan nasional (SKN) Indonesia dengan blok-blok WHO untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan kebijakan, seringkali ditemukan dalam dokumen seperti laporan Bappenas atau Kemenkes, untuk mencapai tujuan kesehatan global/*universal health coverage* (UHC) dan ketahanan kesehatan (*health security*).

Sistem kesehatan global dari WHO mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan di berbagai negara. Setiap negara selalu diperhadapkan dengan masalah kesehatan yang terus berkembang dan membutuhkan respon penanganan cepat dan efektif dari berbagai unsur kesehatan. Setiap negara proaktif dalam memperkuat sistem kesehatannya dengan meningkatkan pelayanan kesehatan baik itu dalam kondisi normal maupun luar biasa (bencana dan krisis) (Tahulending, 2025). Pendekatan *building blocks* ini menekankan bahwa pembenahan di satu elemen saja tidak akan cukup tanpa sinkronisasi dengan elemen lain karena masing-masing pilar memiliki peranan strategis dalam pencapaian tujuan sistem kesehatan, termasuk dalam meningkatkan kualitas layanan, pemerataan akses, dan efektivitas promosi kesehatan (Anggraini, 2024).

Dalam banyak kasus, masalah mendasar terletak pada sistem kesehatan yang lebih luas dan kemampuannya untuk memberikan intervensi kepada mereka yang membutuhkannya. Kelemahan dan hambatan ada di seluruh sistem, termasuk masalah pengelolaan dan manajemen secara keseluruhan, masalah sisi penanganan yang kritis seperti sumber daya manusia, infrastruktur, informasi, dan

penyediaan pelayanan dan masalah-masalah sampingan sistem kesehatan seperti partisipasi, pengetahuan, dan perilaku individu (Mawarni, 2019). Untuk itu, perlu merancang intervensi dan mengevaluasi efek, untuk intervensi penguatan sistem kesehatan dan untuk intervensi yang menargetkan penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dalam mengantisipasi timbulnya kelemahan dan hambatan sistem kesehatan di Indonesia.

Sistem kesehatan sering dipandang sebagai monolitik, sebagai sistem makro dengan sedikit perhatian terhadap interaksi antara bagian-bagian komponennya, padahal sebenarnya sistem kesehatan merupakan penggerak (dinamo) interaksi, sinergi, dan sub-sistem yang bergeser. Seperti dalam sistem kesehatan terdapat sub-sistem untuk penyediaan pelayanan, sub-sistem tersebut mungkin menaungi sistem rumah sakit, dan sistem laboratorium yang saling bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sehingga, semua sub-sistem ini terdapat reaksi, sinergi, dan interaksi dengan tingkat yang berbeda-beda dengan semua blok bangunan sistem kesehatan lainnya.

Untuk mengetahui permasalahan dan kelemahan pada sistem kesehatan, maka dibutuhkan implementasi dengan menerapkan langkah strategis dan penting yang harus diselesaikan. Terlepas dari seberapa efektif suatu implementasi sistem kesehatan, maka sistem tersebut tidak akan mencapai tujuannya jika tidak diterapkan. Untuk mencapai tujuan sistem atau program, implementasi melibatkan semua pihak, institusi, proses, dan elemen teknologi. Ada dua kemungkinan hasil dalam hal implementasi sistem berupa sistem tersebut berhasil diimplementasikan, atau sistem tersebut tidak berhasil diimplementasikan. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sistem sangat dipengaruhi oleh proses pembuatan sistem berbasis data dan bukti.

B. Analisis 6 Building Blocks WHO (*World Health Organization*)

Konsep sistem kesehatan terus bergulir hingga pada tahun 2000, dimana WHO meluncurkan *The World Health Report 2000* yang memberikan landasan baru bagi pembangunan sistem kesehatan. Laporan ini menerbitkan indeks performa sistem kesehatan untuk mencapai tiga tujuan utamanya, yaitu kesehatan yang baik (*good health*), responsivitas terhadap ekspektasi masyarakat (*responsiveness to the expectations of the population*), dan keadilan kontribusi finansial (*fairness of financial contribution*). Selain itu, dokumen *WHO Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes* menyajikan kerangka kerja yang memperbarui kerangka sistem kesehatan dengan enam elemen utama. Dalam format sistem ini, terdapat delapan tujuan sistem yang terbagi menjadi dua tataran yaitu *output* dan *outcome*. Pada tataran *output*, tujuan yang diharapkan

adalah akses, cakupan, mutu, dan keamanan pelayanan kesehatan. Sementara pada tataran *outcome*, tujuan yang harus dicapai adalah peningkatan status kesehatan yang merata, responsif, perlindungan risiko finansial, serta efisiensi (Gani et.al., 2023).

Dalam konteks sistem kesehatan nasional, umumnya lebih dikenal pembagian pelayanan kesehatan berdasarkan tingkatan kebutuhan kesehatan pada populasi berupa pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan atas pelayanan kesehatan antar individu bervariasi, tidak dapat diprediksi, serta belum tentu sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Untuk itu, analisis sistem kesehatan merupakan proses sistematis untuk memahami, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem yang memengaruhi sektor kesehatan yang bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem yang memengaruhi sektor kesehatan, guna memastikan sistem kesehatan tersebut efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ahmad & Bonso, 2022). Sistem akan efektif apabila tujuan tersebut jelas dan terukur, yang berarti tujuan sebuah sistem kesehatan harus didefinisikan secara konseptual dan secara operasional, dengan indikator spesifik yang bisa diukur, yaitu: (Bappenas, 2024)

1. Layanan kesehatan (*service delivery*): Cara penyediaan layanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dan kualitasnya.

Upaya layanan kesehatan diselenggarakan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia sebagai ketahanan nasional dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan, pada fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan. Analisis sistem berfokus pada pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang komprehensif, terintegrasi dari puskesmas hingga rumah sakit

Intervensi kesehatan individu dan non-individu (komunitas) yang efektif, aman, dan berkualitas yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, kapan dan dimana pelayanan itu dibutuhkan (termasuk infrastruktur), dengan menekan pemborosan sumber daya secara maksimal. Untuk itu, fokus penguatan pada Puskesmas, Posyandu, dan jejaring rujukan untuk upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan memprioritaskan aspek promotif dan preventif termasuk penanganan awal suatu kasus kesehatan sebelum memburuk. Puskesmas sebagai garis terdepan dalam penyediaan layanan UKP (usaha kesehatan perorangan) dan UKM (usaha kesehatan masyarakat) dalam pelayanan kesehatan primer sering terkendala

dengan luasnya wilayah layanan maupun besarnya jumlah penduduk dalam sebuah kecamatan wilayah kerjanya. Selain itu, peran kader sangat vital dalam menggerakkan masyarakat dan mendukung ketersediaan layanan dasar di tingkat desa sehingga penguatan pelayanan kesehatan primer di desa perlu didukung dengan pelebagaan kader kesehatan sebagai bagian dari SKN dan daerah kedepannya.

Analisis upaya kesehatan di Indonesia dalam penyediaan layanan kesehatan, Indonesia mengadopsi model campuran pelayanan kesehatan oleh publik dan swasta, namun terkendala pada ketersediaan SDM kesehatan yang mempengaruhi indikator kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, dengan kondisi wilayah geografis Indonesia yang luas, membutuhkan inovasi dan afirmasi khusus baik dari sistem pelayanan, pemerataan akses kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.

2. Tenaga kesehatan (health workforce): Ketersediaan, distribusi, dan kualitas SDM kesehatan.

SDM kesehatan merupakan aspek esensial yang menjadi penyedia pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, SDM kesehatan harus diatur dalam suatu proses sistem kesehatan yang dinamis. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan perlu dilakukan untuk menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Membentuk tenaga kesehatan yang responsif, adil dan efisien mengingat ketersediaan sumber daya dan ketersediaan dalam jumlah yang memadai. Pengaturan SDM kesehatan harus mencakup standar jumlah, jenis, dan kualitas serta pendistribusiannya yang merata.

Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan terbagi atas perencanaan kebutuhan dan program sumber daya manusia yang diperlukan, pengadaan yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, termasuk peningkatan kesejahteraannya, dan pembinaan serta pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. Selain itu, dibutuhkan deformasi pendidikan kesehatan, distribusi tenaga medis ke daerah terpencil (DTPK), dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk penanganan penyakit prioritas.

Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan harus memperhatikan kebutuhan SDM kesehatan yang diutamakan pada setiap jenjang upaya kesehatan. Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan dilakukan di seluruh jenjang

pemerintahan, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan tidak hanya dilakukan untuk jangka pendek tetapi juga proyeksi jangka panjang. Perencanaan kebutuhan dilakukan berdasarkan jenis, jumlah, dan kualifikasi dengan memperhatikan tujuan pembangunan dan kecenderungan masalah kesehatan di masa depan. Perencanaan kebutuhan ini juga harus berdasarkan pada bukti ilmiah dan didukung sistem informasi SDM kesehatan. Selain itu, pembinaan dan pengawasan praktik profesi bagi tenaga kesehatan dilakukan melalui uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan pemberian izin praktik/izin kerja tenaga kesehatan. Sementara untuk tenaga kesehatan yang telah bertugas, pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui sistem karir, penggajian, dan insentif, sedangkan pengawasan SDM kesehatan lebih ditekankan pada pelanggaran etika/disiplin/hukum sesuai aturan yang berlaku. Pembinaan dan peningkatan mutu tidak hanya diberikan kepada tenaga kesehatan tetapi juga kepada SDM kesehatan yang melaksanakan aspek manajerial sistem kesehatan.

Hasil analisis pada tenaga kesehatan diketahui kualitas perguruan tinggi kesehatan yang masih rendah di Indonesia dengan hanya 15,5% Program Studi bidang kesehatan yang terakreditasi A dan pemerataan kualitas dan distribusi lulusan tenaga kesehatan yang kurang merata. Masih terdapat Puskesmas di Indonesia yang belum mempunyai tenaga dokter, serta terbatasnya tenaga dokter spesialis di rumah sakit Kabupaten/Kota disebabkan oleh kurangnya minat penempatan di daerah terpencil karena faktor jauh dari keluarga, keterbatasan pasien, dan keterbatasan kesempatan peningkatan kapasitas (Harahap, 2019).

3. Informasi kesehatan (health information): Sistem pengumpulan, analisis, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan.

Memastikan produksi, analisis, penyebaran, dan penggunaan informasi yang handal dan tepat waktu pada faktor-faktor penentu (determinan) kesehatan, kinerja sistem kesehatan, dan status kesehatan. Manajemen kesehatan memiliki peran dalam koordinasi, integrasi, regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai subsistem sistem kesehatan nasional agar efektif, efisien, dan transparansi, serta pengelolaan data untuk pengambilan kebijakan berdasarkan data (*evidence-based policy*).

Transformasi digital melalui platform terintegrasi seperti SATUSEHAT, digitalisasi puskesmas/RS, dan penguatan surveilans berbasis masyarakat. Dalam sistem kesehatan nasional, terdapat sistem informasi kesehatan (SIK) merupakan bagian dari sub sistem manajemen, informasi dan regulasi

kesehatan. Subsistem manajemen dan informasi kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan fungsi-fungsi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan dan hukum kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna. Dengan subsistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dapat mendukung penyelenggaraan keenam subsistem lain dalam sistem kesehatan nasional sebagai satu kesatuan yang terpadu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pemanfaatan teknologi dalam pembangunan kesehatan diarahkan pada dua hal (digitalisasi pelayanan kesehatan dan digitalisasi sistem informasi kesehatan). Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan banyak kendala dalam upaya digitalisasi pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi di sektor kesehatan juga masih belum optimal seperti pengembangan *telemedicine*. Perkembangan tersebut menuntut akselerasi perhatian Pemerintah dalam mengelola ekosistem teknologi pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional.

Sistem informasi kesehatan yang ada saat ini berupa aplikasi dan sistem pelaporan yang hendaknya terintegrasi dengan baik. Ketika sistem informasi kesehatan tidak terintegrasi akan berimplikasi pada meningkatnya beban administrasi di fasilitas kesehatan mengingat potensi duplikasi dan tidak sinkronnya data antara sistem informasi pusat dan daerah yang tinggi. Untuk selanjutnya, digitalisasi menjadi *drivers* utama dalam reformasi sistem kesehatan nasional, sehingga menjadi hal yang perlu ditingkatkan pemanfaatannya dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pelayanan kesehatan dan pemanfaatan data kesehatan.

Analisis informasi kesehatan masih menemukan banyak kendala dalam upaya digitalisasi pelayanan kesehatan, termasuk dalam keterbatasan peralatan teknologi, hambatan ketersediaan jaringan internet, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, maupun aplikasi dan sistem pelaporan yang belum terintegrasi. Untuk itu, peran teknologi sangat penting dalam mendukung program kesehatan yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4. Akses keuangan/pembiayaan (health financing): Mekanisme pengumpulan dana dan pembayaran layanan, termasuk BPJS.

Subsistem pembiayaan kesehatan dengan tujuan tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang memadai teralokasi secara adil, merata, dan

termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, sangat penting dalam pembangunan kesehatan dan menekankan prinsip pembiayaan kesehatan (kecukupan, efektif dan efisien, dan adil dan transparan). Pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan organisasi masyarakat serta masyarakat itu sendiri. Pembiayaan kesehatan harus diselenggarakan secara adekuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan. Mengumpulkan dana yang memadai untuk kesehatan dengan cara memastikan orang dapat menggunakan pelayanan yang diperlukan, dan dilindungi dari krisis keuangan atau kemiskinan yang terkait dengan keharusan membayar bagi mereka yang membutuhkan. Peran evaluasi pembiayaan kesehatan juga dibutuhkan agar biaya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pembiayaan kesehatan yang berjalan sudah memenuhi norma-norma pembiayaan serta apakah dana yang digunakan sudah memenuhi kebutuhan atau tidak. Secara rutin monitoring dilakukan dengan menilai laporan realisasi anggaran. Sedangkan untuk evaluasi, kegiatan penilaian akun kesehatan (*health account*) harus secara reguler dilakukan setiap tahun sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana pembiayaan kesehatan sudah mendekati norma-norma pembiayaan yang berlaku.

Subsistem pembiayaan kesehatan dapat juga dilakukan dengan penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS Kesehatan), reformasi pembayaran fasilitas kesehatan, dan meningkatkan efisiensi alokasi anggaran pusat-daerah yang dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan tanpa kendala finansial (*Universal Health Coverage*). Namun, pembiayaan kesehatan di Indonesia saat ini termasuk yang paling rendah di dunia. Indonesia masih rendah dalam membelanjakan pengeluaran kesehatan per kapita maupun proporsi terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan kesehatan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB dan APBN. Ke depan, pembiayaan kesehatan akan terus meningkat dan jika komposisi pembiayaan kesehatan masih seperti sekarang, maka beban anggaran pemerintah untuk kesehatan akan meningkat dan tidak berkelanjutan.

Permasalahan yang timbul dari pembiayaan kesehatan antara lain kurangnya dana serta adanya peningkatan dana. Kurangnya dana terjadi karena terdapatnya inefisiensi dalam pengelolaan pembiayaan dan alokasi dana yang salah. yaitu adanya trend peningkatan teknologi kedokteran sebagai penegak diagnosis (*evidence bases*) yang menyebabkan konsekuensi biaya, serta *tren supply induce demand* yang banyak marak sekarang ini (Trisnantoro, 2014). Selain itu, dominasi pembiayaan dengan mekanisme *fee for service*, dan masih

kurangnya dalam mengalokasikan sumber-sumber dan pelayanan itu sendiri (*poor management of sesources and services*) (Kemenkes RI, 2019).

5. Obat & teknologi medis (*medicines & technologies*): Ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas obat serta teknologi.

Subsistem ini meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem farmasi dimulai dari penyediaan lingkungan yang suportif terhadap penemuan atau inovasi, pendaftaran, peredaran, pengawasan kualitas, harga dan kompetisi, hingga akses masyarakat terhadap obat-obatan, alat kesehatan dan makanan.

Produk medis, vaksin dan teknologi lain dengan kualitas terjamin, keamanan, kemanjuran (efikasi), efektivitas biaya, dan penggunaannya yang ilmiah dan hemat biaya. Penjaminan, perlindungan masyarakat dari penggunaan obat yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional, serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian. Ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan diatasi dengan penggunaan e-katalog untuk pengadaan obat, peningkatan produksi obat dan alkes dalam negeri, serta memperkuat rantai pasok logistik kesehatan.

Dalam subsistem obat dan teknologi medis diketahui masih dihadapkan pada masih tinggi ketergantungan impor terhadap bahan baku obat dan teknologi medis. Hal ini disebabkan karena belum adanya kemandirian farmasi dan alat kesehatan, dimana dana belanja alat kesehatan masih didominasi oleh produk impor dan anggaran penelitian dan pengembangan yang masih rendah (Kemenkes RI, 2019). Untuk itu, perlu diperkuat riset dan pengembangan industri hulu (bahan baku), serta iklim usaha dan regulasi yang mendukung kemandirian dalam negeri.

6. Kepemimpinan & tata kelola (*leadership & governance*): Kebijakan, regulasi, dan pengawasan untuk mengarahkan sistem kesehatan.

Manajemen kesehatan berperan dalam koordinasi, integrasi, regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai subsistem SKN agar efektif, efisien, dan transparan dalam penyelenggaraan SKN. Sistem kesehatan memerlukan kepemimpinan yang kuat dan efektif untuk menggerakkan semua subsistem

kesehatan mencapai tujuan-tujuan sistem tersebut. Kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan dalam sistem kesehatan merupakan elemen kunci yang menentukan arah, koordinasi, dan konsistensi kebijakan kesehatan, termasuk dalam penguatan promosi kesehatan. Pemerintah dan pemangku kebijakan berperan menetapkan visi strategis, regulasi, serta mekanisme koordinasi lintas sektor yang mampu mengintegrasikan berbagai komponen sistem kesehatan seperti layanan primer, pembiayaan, dan sistem informasi agar tujuan promotif-preventif dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan (Anggraini, 2024)

Kepemimpinan memastikan kerangka kerja kebijakan strategis yang dikombinasikan dengan pengawasan yang efektif, pembangunan kerjasama lintas sektoral, akuntabilitas, regulasi, insentif dan perhatian terhadap desain sistem. Dukungan terhadap transformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) melalui Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, penguatan peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam integrasi UKM/UKP, serta peningkatan transparansi manajemen kesehatan dari tingkat nasional sampai tingkat provinsi dan daerah. Berbagai kajian kebijakan di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas tata kelola yang baik ditandai oleh kepemimpinan yang kuat, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi pemangku kepentingan berpengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi program kesehatan, terutama dalam menghadapi tantangan kompleks seperti disparitas akses layanan, koordinasi antar lembaga, dan alokasi sumber daya yang adil dan efisien, sehingga mampu mendukung terciptanya sistem kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi (Bappenas, 2024).

Dalam tata kelola urusan sistem kesehatan nasional berfungsi mengawal penyusunan rencana kesehatan agar konsisten dengan tujuan SKN. Tata kelola yang dilakukan berorientasi tujuan (*objective oriented administration*) yang jelas dengan indikator terukur. Di Indonesia, administrasi kesehatan tersebut secara nasional mengikuti tata kelola urusan pemerintah dalam suatu sistem desentralisasi, baik desentralisasi kewenangan, fungsi, dan fiskal dengan pembagian tugas untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Selain itu, perlu juga melakukan tata kelola intervensi pelayanan kesehatan yang memberikan batasan tugas dan koordinasi antara dinas kesehatan, RS dan Puskesmas agar pelayanan terintegrasi dapat berjalan normal untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat, dimana memerlukan peningkatan literasi masyarakat dan pengurangan batasan sosial, budaya, finansial, dan gender terhadap pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan SKN perlu memperhatikan dinamika sosial budaya, agama, politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, aparatur dan birokrasi, keamanan, pangan dan

pertanian, lingkungan, dan infrastruktur yang mempengaruhi pembangunan kesehatan.

C. Tantangan Sistem Kesehatan

Perkembangan global (globalisasi) memiliki implikasi yang luas bagi kesehatan masyarakat, karena semakin meningkatnya perjalanan dan perdagangan antar negara, dan menjadi salah satu faktor penyebaran penyakit dan ancaman kesehatan lintas batas negara. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan kesehatan tidak dapat diatasi oleh satu negara atau sektor saja, tetapi diperlukan kerja sama antar negara. Kesehatan global berfokus pada isu-isu kesehatan dunia yang membutuhkan kerja sama lintas negara, bersifat multidisipliner, lintas sektor, dan bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai kesetaraan status kesehatan masyarakat dunia.

Kerja sama global merupakan wujud dari kemitraan global, baik kerja sama multilateral (melibatkan banyak negara) maupun kerja sama bilateral (antara dua negara), sangat penting dalam mewujudkan kesehatan global. Kerja sama multilateral maupun kerja sama bilateral memungkinkan pengembangan program kesehatan spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara mitra ditujukan untuk memberikan manfaat bersama dan mendorong kemajuan menuju peningkatan standar kesehatan baik di antara negara-negara yang saling menghormati maupun secara bilateral.

Berdasarkan kondisi global dan juga kondisi kesehatan Indonesia, selanjutnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan penataan sistem kesehatan Indonesia melalui transformasi kesehatan, sebagai bentuk implementasi kebijakan kesehatan global. Dalam implementasi sistem kesehatan Indonesia terdapat beberapa isu strategis yang belum tercakup dan dibahas mendalam dalam sistem kesehatan yang saat ini ada, yaitu : (Bappenas, 2023)

1. Desentralisasi

Proses dan perkembangan desentralisasi tata kelola pemerintah daerah tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014, PP No.18 tahun 2016, PP No. 2 tahun 2018 dan UU No. 1 tahun 2022. Pada perkembangan desentralisasi tata kelola pemerintah tersebut belum terakomodir dalam sistem kesehatan Indonesia. Pada situasi tertentu, dibutuhkan intervensi pusat ke daerah untuk menyelesaikan masalah kronis pembangunan kesehatan dan kedaruratan kesehatan. Proses desentralisasi sistem kesehatan ke daerah pernah mengalami kegagalan, seperti pada pandemi Covid-19. Kegagalan dalam implementasi

kebijakan seringkali disebabkan oleh adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, dimana dapat terjadi karena kebijakan yang kurang baik (*bad policy*), implementasi yang kurang efektif (*bad implementation*), atau faktor-faktor eksternal yang tidak terduga (*bad luck*) (Rusdian & Widiarini, 2020). Untuk itu, dinas kesehatan merupakan penggerak kunci penanganan pandemi yang bersifat lintas sektor di daerah. Kemampuan khusus tentang epidemiologi serta manajerial koordinasi harus dimiliki oleh dinas kesehatan.

2. Ketahanan kesehatan

Pembangunan kesehatan mendapatkan tantangan baru saat pandemi Covid-19, dimana terjadi kerentanan dalam sistem kesehatan yang berdampak pada pembangunan kesehatan. Selain itu, ancaman kesehatan berupa *antimicrobial resistance* (AMR), food security, dan perubahan iklim berdampak pada perubahan pola penyakit. Situasi darurat kesehatan dan sistem kesehatan yang tidak mumpuni berdampak pada banyaknya korban yang meninggal. Kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan nasional pun turut terdampak. Hal ini memberikan pesan kritis bahwa pengelolaan ketahanan kesehatan harus dilakukan dengan serius dan terencana dengan baik.

Kegawatdaruratan kesehatan masyarakat dapat terjadi kapan saja dan merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi. Di satu sisi, kondisi tersebut harus ditangani dengan cepat dan di sisi lain pelayanan rutin juga tidak boleh terlewatkan. Dalam memperkuat sistem kesehatan yang tangguh membutuhkan peran serta aktif pemerintah dan masyarakat baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Koordinasi lintas sektor merupakan titik lemah dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2019).

Dalam aspek pengendalian penyakit selain peningkatan penyakit tidak menular, Indonesia masih harus menghadapi penyakit menular dan masih ditemukan penyakit tropis terabaikan (*neglected tropical diseases*) (Gani dan Budiharsana, 2019). Hingga tahun 2021, cakupan pengobatan TB hanya 46% dengan keberhasilan pengobatan hanya 83%, masih terdapat 3 provinsi dengan endemisitas malaria yang tinggi adalah Papua, Papua Barat, dan NTT. Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus kusta tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Brazil. Capaian imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan sebesar 57,9% (Riskesdas, 2018) dan 65,8 (SSGI, 2021) masih rendah bila dibandingkan dengan target yang perlu dicapai pada tahun 2024 (Kemenkes RI, 2021).

3. Pelayanan kesehatan primer (*Primary Health Care*).

Pelayanan kesehatan primer merupakan pelayanan kesehatan terdekat dari masyarakat dan merupakan jantung dari sistem kesehatan. Dengan penekanan pada pendekatan pencegahan dan promosi, transformasi layanan kesehatan primer memerlukan perhatian khusus dan investasi kesehatan yang besar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan integrasi layanan kesehatan primer dengan memperkuat pemantauan daerah lokal melalui penggunaan dasbor situasi kesehatan per desa, memperluas layanan kesehatan melalui jaringan hingga tingkat desa dan dusun, serta menekankan siklus hidup sebagai fokus integritas layanan.

Di Indonesia upaya pelayanan kesehatan primer dilaksanakan oleh Puskesmas. Puskesmas adalah institusi pelayanan kesehatan primer yang unik di dunia, karena Puskesmas melaksanakan UKM (upaya kesehatan masyarakat) dan UKP (upaya kesehatan perorangan) secara bersamaan (terintegrasi dan menghilangkan dikotomi UKM-UKP). Puskesmas juga melaksanakan pelayanan secara komprehensif meliputi lima jenjang pelayanan (promotif, preventif, skrining, pengobatan dan rehabilitasi). Keunikan lain berupa fungsi utama Puskesmas sebagai pembina kesehatan wilayah. Konsep kewilayahan tersebut menjadi ciri khas Puskesmas sejak awal didirikan, namun dilupakan dalam perjalanan waktu. Hal ini akibat dampak adanya peran Puskesmas dijadikan sebagai provider layanan primer dalam sistem JKN, adanya moratorium pengangkatan PNS, dan kebijakan desentralisasi.

Ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas masih belum mencukupi dan jenis petugas minimal puskesmas sesuai standar masih belum terpenuhi. Ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas masih belum mencukupi. Ketersediaan sarana & prasarana penunjang masih bervariasi antar fasyankes dan alat kesehatan masih belum terpenuhi secara lengkap di fasyankes primer. Di era desentralisasi, kendali pusat atas masalah kesehatan di tingkat kabupaten/kota mulai berkurang, sehingga perkembangan pelayanan kesehatan dasar antardaerah bervariasi tergantung pada komitmen daerah, kapasitas fiskal, serta pemenuhan fasilitas, SDM, sarana dan prasarana (Bappenas, 2018).

Tantangan terbesar FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) termasuk puskesmas di era JKN ini adalah memperkuat upaya promotif dan preventif. Pelayanan kuratif cenderung menjadi kegiatan utama di FKTP dibandingkan upaya mendorong hidup sehat seperti edukasi, surveilans, maupun pemberdayaan masyarakat. Pelibatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta masih rendah, sementara itu potensi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh

pihak swasta cukup tinggi. Keterlibatan swasta dalam peningkatan akses maupun kualitas RS di Indonesia cukup vital dan perlu dilibatkan dalam sistem rujukan maupun layanan unggulan yang berlaku saat ini. Ini masih banyak FKTP yang merujuk pasien pada fasyankes sekunder dan tersier karena ketidakmampuan melakukan penanganan kasus, sementara itu sistem rujukan berbasis kompetensi juga masih terkendala geografis, jarak, transportasi, dan pendanaan (Wibisana, 2019).

D. Implementasi Sistem Kesehatan Indonesia

Indonesia merespons perkembangan sistem kesehatan global ini secara bertahap. Setelah terbitnya sistem kesehatan nasional (SKN) tahun 1982, SKN mengalami beberapa kali perbaikan dengan mempertimbangkan situasi nasional dan global. Sistem kesehatan nasional (SKN) tahun 2004 terbit dengan mempertimbangkan perubahan dan tantangan pasca reformasi politik 1998 dan perubahan konteks pengelolaan pemerintahan setelah kebijakan desentralisasi. Pada tahun 2009, sistem kesehatan nasional (SKN) diperbarui dengan memberikan penekanan pada revitalisasi layanan kesehatan primer (Gani et.al., 2023).

Berbagai perubahan format SKN menunjukkan bahwa SKN dirancang terbuka dan adaptif, sehingga dapat diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis. Adapun lingkungan strategis yang dimaksud dapat berasal dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan, dan terjadi pada tatanan global, regional, dan nasional. Pada tingkat global dan regional, perkembangan mobilitas penduduk dan industrialisasi yang bergantung pada pasar internasional mempengaruhi dinamika situasi ekonomi di tingkat dunia maupun nasional yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan resesi ekonomi. Perubahan geopolitik juga terjadi di tingkat regional dan global, sehingga memengaruhi kebijakan kesehatan di tingkat tersebut. Posisi geopolitik Indonesia pada regional ASEAN maupun Asia Pasifik juga mempengaruhi model SKN yang dikembangkan.

Sistem kesehatan nasional (SKN) mengalami perubahan kembali pada tahun 2012 melalui Perpres No. 72 tahun 2012. Dalam SKN 2012, tujuan yang ditetapkan masih merujuk pada kerangka sistem kesehatan WHO 2000, yaitu meningkatkan derajat kesehatan penduduk setinggi-tingginya. Meski demikian, subsistem dalam SKN 2012 bukan hanya mengadopsi enam elemen utama sistem kesehatan WHO 2007, namun juga menambahkan komponen subsistem pemberdayaan masyarakat sebagai elemen pokok atau subsistem. Tambahan subsistem pemberdayaan masyarakat dalam SKN 2012 didasarkan pada peran masyarakat yang sangat vital dalam konteks Indonesia dan menyangkut peran serta masyarakat sebagai modal sosial yang besar dan mampu menjadi bagian dari daya

ungkit SKN 2012 (Gani et.al., 2023). SKN 2012 telah menjadi panduan yang baik bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Walaupun demikian, SKN 2012 tidak secara detail menjelaskan interaksi antarsubsistem kesehatan. Hal ini menyebabkan pembangunan antar komponen kesehatan seperti terpisah-pisah, padahal tidak mungkin suatu komponen berjalan dengan baik tanpa dukungan komponen lain. Selain itu dalam lingkungan strategis yang berubah cepat, SKN 2012 belum secara eksplisit menjelaskan mekanisme koordinasi dan keterlibatan dengan sistem lain seperti pendidikan, IPTEK, industri, transportasi, keuangan, perencanaan, dan lain.

Sistem kesehatan nasional (SKN) merupakan bagian penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Dalam Kesehatan Untuk Semua, setiap penduduk dapat hidup sehat baik fisik, mental dan sosial, memiliki kemauan dan kemampuan hidup sehat agar mampu berpartisipasi dan berperan dalam setiap aspek pembangunan. Semua penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik pelayanan kesehatan primer dan rujukan dan mencakup seluruh jenis pelayanan. Upaya preventif, promotif, peningkatan literasi kesehatan dan kemampuan untuk menjaga kesehatan secara mandiri perlu diintegrasikan pada seluruh bentuk pelayanan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Bappenas sering menggunakan kerangka 6 *Building Blocks* Sistem kesehatan ini untuk mengevaluasi sistem kesehatan nasional (SKN). Dalam merumuskan prioritas kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan memperhatikan berbagai masukan dari pemangku kepentingan, antara lain : (Bappenas, 2024)

1. Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan kesehatan yang dihadapi individu sejak bayi hingga usia lanjut
2. Indonesia perlu membangun sistem dan kapasitas yang kuat untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi wabah penyakit menular secara efektif, memastikan gangguan minimal terhadap masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan
3. Indonesia perlu memastikan akses yang tepat waktu dan mudah ke layanan yang memenuhi standar yang ditetapkan dan mendorong hasil yang positif, sekaligus meminimalkan hambatan finansial untuk perawatan
4. Mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya keuangan dalam sistem pelayanan kesehatan untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih baik sekaligus meminimalkan pemborosan dan inefisiensi.

Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (2024) juga menyusun prioritas di bidang kesehatan, yaitu:

1. Menjamin kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia untuk mewujudkan tujuan transformasi sosial dalam visi Indonesia Emas 2045
2. Meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup seluruh penduduk Indonesia sebagai indikator keberhasilan sektor kesehatan.
3. Meningkatkan kesehatan fisik, kognitif, dan mental di semua tahap kehidupan, memiliki risiko penyakit, kematian dini, dan biaya perawatan kesehatan yang lebih rendah
4. Memanfaatkan peluang dalam pengembangan teknologi untuk lebih meningkatkan sistem kesehatan

Saat ini Indonesia sedang mengalami ketiga tahapan evolusi permasalahan kesehatan pada rentang waktu bersamaan, dimana permasalahan mendasar (tahap awal), penyakit menular dan masalah gizi masih tinggi, disertai masalah patologi sosial dan lingkungan telah menjadi ancaman. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka jaringan pelayanan kesehatan primer adalah pelayanan yang paling dekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat dan berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Puskesmas dan jaringannya berpotensi mendukung pencapaian cita-cita kesehatan untuk semua, melalui fungsi pemerataan pelayanan kepada seluruh penduduk dengan partisipasi masyarakat. Namun, dengan jumlah Puskesmas dan jaringannya yang terbatas, penambahan jumlah penduduk dan dinamika epidemiologi dan sosial determinan kesehatan yang semakin kompleks, maka perlu perluasan dan penguatan pelayanan kesehatan primer melalui Puskesmas dan jaringannya.

Belajar dari pandemi Covid-19, penguatan *prevent, detect, respond* (PDR) didukung sistem surveilans yang berjenjang dari tingkat masyarakat sampai ke tingkat pusat. Penerapan surveilans berbasis masyarakat harus disertai dengan peningkatan kapasitas masyarakat serta penyesuaian dengan kearifan lokal dengan menitikberatkan peningkatan kapasitas dinas kesehatan dan puskesmas sebagai penanggung jawab UKM di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Selain itu, koordinasi kuat antara pengampu kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan juga harus dibangun secara rutin dalam rangka memperkuat deteksi dini potensi wabah.

Memperhatikan kondisi geografis wilayah dengan pengembangan sistem rujukan terutama di wilayah kepulauan dan pegunungan yang bertujuan untuk menjamin pemerataan akses, dan memastikan pelayanan kesehatan berkualitas yang dicerminkan oleh *responsiveness*, waktu tunggu, perilaku layanan tenaga kesehatan, tingkat cakupan sasaran, kepuasan pasien. Selain itu, pelayanan kesehatan terintegrasi menekankan bahwa pendekatan pelayanan kesehatan berbasis penyakit dan institusi kesehatan yang komprehensif di tingkat dasar, tidak

hanya puskesmas tetapi juga mencakup fungsi kesehatan masyarakat, pelibatan komunitas, serta kolaborasi dan aksi multipihak. Ketelibatan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap aktivitas pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam pembangunan berwawasan kesehatan perlu ditingkatkan setiap waktu.

Kebutuhan dalam perencanaan dan pemenuhan SDM kesehatan, ketersediaan farmasi dan teknologi kesehatan dengan mengutamakan mutu, keamanan, dan penggunaan yang rasional. Perencanaan dan penyelenggaraan SDM kesehatan membutuhkan pembinaan dan pengawasan praktik profesi bagi tenaga kesehatan. Kebutuhan farmasi perlu memastikan kemandirian farmasi dan alat kesehatan tanpa bergantung pada pasokan dari luar negeri. Penguatan kebijakan kesehatan untuk mendukung produksi bahan obat dalam negeri perlu dilakukan penetapan prioritas secara lebih sistematis dan menyeluruh.

E. Referensi

-
- Ahmad, B., & Bonso, H. (2022). Dampak pandemi terhadap peningkatan fungsi ibu rumah tangga dalam keluarga (Studi kasus ibu-ibu wali murid SD Yapis 2 Samofa Biak Numfor-Papua). *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6 (1), pp. 1880–1887. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2685>
- Anggraini, S. (2024). *Dari pelayanan kuratif ke preventif: Peran WHO six building blocks dalam penguatan promosi kesehatan di Indonesia*. Depok : Indonesia
- Gani & Budiharsana. (2019). *Fungsi kesehatan masyarakat (public health functions) dan health security*. Jakarta: Kementerian PPN/ Bappenas
- Gani et. al., (2023). *Review dan reformulasi sistem kesehatan nasional Indonesia*. Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas
- Hapsara, H. (2019). *Pembangunan kesehatan dengan menguatkan sistem kesehatan nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Harahap Nida. (2019). *Kajian sektor kesehatan: Sumber daya manusia kesehatan*. Jakarta: Kementerian PPN/ Bappenas
- Harahap, N. (2019). *Sumber daya manusia kesehatan*. Jakarta: Kementerian PPN/ Bappenas
- Kementerian Kesehatan. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan RI, No. 4 Tahun 2019, *tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Buku putih reformasi sistem kesehatan nasional*. Jakarta: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kedeputan

Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas

Mawarni, D. (2009). *Berpikir sistem untuk penguatan sistem kesehatan*. Malang: Wineka Media

Rusdian, E. R., & Widiarini, R. (2020). Evaluasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK): Studi kasus di tingkat puskesmas evaluation of the healthy Indonesia program with the family approach (PIS-PK). A case study at primary health service. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : Jkki*, 9(01), 1–8.

Tahulending, A.A (2025). *Analisis kebijakan kesehatan*. Cilacap : Media Pustaka Indo

Wibisana, W. (2019). *Penguatan sistem pelayanan kesehatan*. Jakarta: Kementerian PPN/ Bappenas

CHAPTER 2

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) , TRANSFORMASI KESEHATAN, SISTEM KESEHATAN , DAN TARGET SDGs TAHUN 2030

I Made Raka, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan / Prolog

1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan global. Di tingkat global, komitmen pembangunan kesehatan tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan tercapainya pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Salah satu tujuan utama SDGs, yaitu Tujuan 3, menekankan pentingnya menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi seluruh penduduk di segala usia.

Di Indonesia, upaya pencapaian target SDGs bidang kesehatan diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya adalah penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN tidak hanya berperan sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam transformasi sistem kesehatan nasional. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan akses, mutu, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Bab ini membahas kebijakan JKN, arah transformasi sistem kesehatan, serta keterkaitannya dengan pencapaian target SDGs tahun 2030 [1–3].

B. Konsep dan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1. Konsep Dasar Jaminan Sosial Kesehatan

Jaminan sosial kesehatan merupakan bagian dari perlindungan sosial yang bertujuan melindungi seluruh penduduk dari risiko finansial akibat masalah kesehatan. Konsep ini menekankan pada prinsip solidaritas sosial, di mana kelompok yang sehat dan mampu secara ekonomi membantu kelompok yang sakit dan kurang mampu. Jaminan sosial kesehatan juga bertujuan mencegah terjadinya pengeluaran kesehatan katastrofik yang dapat menurunkan kesejahteraan rumah tangga.

Dalam konteks global, jaminan sosial kesehatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana

seluruh penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial. Indonesia mengadopsi konsep ini melalui implementasi JKN sebagai sistem jaminan kesehatan nasional yang bersifat wajib dan menyeluruh.

2. Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

3. Landasan Hukum JKN

Penyelenggaraan JKN didasarkan pada beberapa regulasi utama, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang terus disempurnakan sesuai kebutuhan sistem kesehatan nasional.

Landasan hukum ini menegaskan peran negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

4. Tujuan dan Prinsip JKN

Tujuan utama JKN adalah memberikan kepastian perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia. Prinsip-prinsip yang mendasari JKN meliputi:

- Gotong royong
- Kepesertaan bersifat wajib
- Nirlaba
- Keadilan dan pemerataan
- Portabilitas
- Dana amanat

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).

C. Transformasi Sistem Kesehatan Nasional

1. Latar Belakang Transformasi Kesehatan

Transformasi sistem kesehatan merupakan proses perubahan mendasar dan berkelanjutan dalam tata kelola, pembiayaan, serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna menjawab dinamika tantangan kesehatan masyarakat. Perubahan demografi, transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan menjadi faktor pendorong utama transformasi sistem kesehatan.

Selain itu, pengalaman global dalam menghadapi krisis kesehatan, seperti pandemi COVID-19, menunjukkan pentingnya sistem kesehatan yang tangguh (resilient), adaptif, dan berorientasi pada pencegahan. Oleh karena itu, transformasi kesehatan tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif, tetapi juga menekankan upaya promotif dan preventif secara terintegrasi [3,4]. Transformasi sistem kesehatan dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses pelayanan kesehatan, beban ganda penyakit, keterbatasan sumber daya kesehatan, serta tuntutan pelayanan yang bermutu dan berkelanjutan. JKN menjadi katalis penting dalam mendorong perubahan tata kelola sistem kesehatan.

2. Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Transformasi sistem kesehatan di Indonesia mencakup beberapa pilar utama, antara lain:

- a. Transformasi layanan primer
- b. Transformasi layanan rujukan
- c. Transformasi sistem ketahanan kesehatan
- d. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan
- e. Transformasi sumber daya manusia kesehatan
- f. Transformasi teknologi kesehatan

Melalui pilar-pilar tersebut, diharapkan sistem kesehatan menjadi lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3. Peran JKN dalam Transformasi Kesehatan

JKN berperan strategis dalam mendorong transformasi kesehatan, khususnya dalam aspek pembiayaan dan akses layanan. Dengan skema pembiayaan yang terintegrasi, JKN mendorong penguatan layanan kesehatan primer, sistem rujukan berjenjang, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

D. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam bidang kesehatan, pembangunan berkelanjutan menempatkan kesehatan sebagai prasyarat, hasil, sekaligus indikator keberhasilan pembangunan. Masyarakat yang sehat memiliki produktivitas lebih tinggi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

E. Gambaran Umum SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. SDGs menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) dan berlaku sejak tahun 2015 hingga 2030.

1. Tujuan 3 SDGs: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 SDGs berfokus pada upaya menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk. Target-target utama dalam tujuan ini meliputi:

- Penurunan angka kematian ibu dan bayi
- Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- Peningkatan akses pelayanan kesehatan esensial
- Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)

2. Indikator Kesehatan dalam SDGs

Indikator kesehatan SDGs mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan layanan kesehatan.

F. Keterkaitan JKN, Transformasi Kesehatan, dan Target SDGs 2030

1. JKN sebagai Instrumen Pencapaian UHC

JKN merupakan instrumen utama Indonesia dalam mencapai UHC, yang menjadi salah satu target kunci SDGs. Dengan cakupan kepesertaan yang luas, JKN berkontribusi langsung terhadap peningkatan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

2. Dukungan Transformasi Kesehatan terhadap SDGs

Transformasi sistem kesehatan memperkuat kapasitas nasional dalam mencapai target SDGs, khususnya melalui peningkatan kualitas layanan, efisiensi pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi kesehatan.

3. Tantangan dan Peluang Menuju 2030

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, masih terdapat tantangan dalam implementasi JKN dan transformasi kesehatan, seperti keberlanjutan pembiayaan, pemerataan tenaga kesehatan, dan disparitas wilayah. Namun demikian, peluang inovasi kebijakan, digitalisasi layanan, dan penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi modal penting menuju pencapaian target SDGs 2030.

G. Penutup

Kebijakan JKN, transformasi sistem kesehatan, dan target SDGs 2030 merupakan tiga elemen yang saling terkait dan saling memperkuat. JKN menjadi fondasi pembiayaan dan akses layanan kesehatan, sementara transformasi sistem kesehatan memastikan peningkatan mutu dan keberlanjutan pelayanan. Sinergi keduanya diharapkan mampu mempercepat pencapaian target SDGs bidang kesehatan, sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan pada tahun 2030 [2,4,5].

H. Referensi

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peta Jalan Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI; 2021.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara; 2011.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara; 2004.
- United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations; 2015.
- World Health Organization. Tracking Universal Health Coverage: 2021 Global Monitoring Report. Geneva: WHO; 2021.

CHAPTER 3

MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER: PUSKESMAS, FAMILY MEDICINE DAN PIS PK

Drg. Arnetty, M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Transformasi Pelayanan Primer sebagai Urgensi Nasional Pelayanan Kesehatan Primer (PKP) di Indonesia saat ini berada pada titik balik krusial melalui kebijakan transformasi kesehatan yang memprioritaskan penguatan promotif dan preventif. Menurut Budi Gunadi Sadikin (2022), transformasi layanan primer merupakan pilar pertama dari enam pilar transformasi kesehatan yang bertujuan untuk menata ulang 10.000 Puskesmas di seluruh Indonesia agar mampu melakukan skrining kesehatan secara proaktif. Urgensi ini didasarkan pada data beban penyakit di mana Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes melitus menyumbang angka kematian tertinggi, yang sebenarnya dapat dicegah jika deteksi dini di tingkat primer berjalan optimal.

Reorientasi Paradigma Sehat dalam Sistem Kesehatan Pergeseran dari model kuratif menuju paradigma sehat memerlukan integrasi sistemik dalam Sistem Kesehatan Nasional. Notoatmodjo (2018) menekankan bahwa kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh layanan medis, tetapi oleh faktor lingkungan dan perilaku yang dikelola melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat dasar. Integrasi ini diperkuat oleh kebijakan integrasi layanan primer (ILP) yang menurut Kementerian Kesehatan RI (2023), mengalihkan fokus Puskesmas dari pelayanan berbasis program menjadi pelayanan berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil hingga lansia.

Manajemen dan Kepemimpinan Puskesmas yang Adaptif Tata kelola organisasi Puskesmas yang efektif menjadi fondasi keberhasilan transformasi kesehatan di tingkat akar rumput. Trisnantoro (2019) dalam studinya mengenai manajemen rumah sakit dan puskesmas menyatakan bahwa kepemimpinan yang adaptif dan budaya sorganisasi yang berorientasi pada mutu adalah kunci utama dalam menghadapi kompleksitas kebutuhan masyarakat. Data menunjukkan bahwa Puskesmas yang memiliki komitmen kepemimpinan tinggi terhadap manajemen mutu cenderung memiliki skor akreditasi lebih baik dan tingkat

keselamatan pasien yang lebih terjamin dibandingkan dengan yang hanya berfokus pada pemenuhan administratif.

Implementasi Family Medicine di Era JKN Penerapan prinsip Kedokteran Keluarga (Family Medicine) memberikan dimensi pelayanan yang lebih personal dan holistik dalam sistem rujukan berjenjang. Menurut Wonodirekso (2020), dokter keluarga bertindak sebagai gatekeeper sekaligus manajer kesehatan pasien yang memahami konteks sosial-ekonomi keluarga secara menyeluruh. Hal ini didukung oleh penelitian Sitorus et al. (2021) yang menemukan bahwa koordinasi asuhan yang dilakukan secara kontinu oleh tenaga medis di Puskesmas dapat menurunkan angka rujukan non-spesialistik ke rumah sakit sebesar 15-20%, sehingga meningkatkan efisiensi biaya kesehatan nasional.

PIS-PK sebagai Instrumen Intervensi Presisi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) hadir sebagai instrumen untuk memetakan status kesehatan masyarakat secara mendetail melalui kunjungan rumah. Berdasarkan laporan Pusat Data dan Informasi Kemenkes (2022), capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) nasional masih menunjukkan disparitas yang lebar antarwilayah, di mana masalah utama masih berkisar pada akses air bersih dan kepatuhan penderita hipertensi dalam berobat. Hartono (2021) berpendapat bahwa data IKS bukan sekadar angka statistik, melainkan alat bagi kepala Puskesmas untuk melakukan "intervensi lanjut" yang spesifik pada klaster keluarga yang memiliki risiko kesehatan tinggi.

Sinergi Digitalisasi dan Keberlanjutan Masa Depan Masa depan pelayanan kesehatan primer bergantung pada keberhasilan digitalisasi data kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Indrajit (2022) menyatakan bahwa integrasi data antara P-Care BPJS dan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) sangat vital untuk menciptakan rekam medis elektronik yang berkesinambungan. Tantangan integrasi antara filosofi Family Medicine dengan teknis PIS-PK, menurut Supriyanto (2023), terletak pada sinkronisasi data lapangan dengan manajemen klinis, namun jika disinergikan dengan baik, hal ini akan menciptakan sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Pendekatan Pelayanan Kesehatan Primer Masa Depan

1. Konsep Transformasi Layanan Kesehatan Primer

Transformasi pelayanan kesehatan primer di Indonesia saat ini tidak lagi dipandang sebagai sekadar perbaikan fasilitas fisik, melainkan sebuah rekayasa ulang (*re-engineering*) terhadap sistem pelayanan yang ada. Adisasmito (2022) menjelaskan bahwa penguatan struktur pelayanan primer merupakan benteng pertahanan utama dalam ketahanan kesehatan nasional, di mana Puskesmas

harus mampu bertransformasi menjadi pusat manajemen kesehatan wilayah yang responsif terhadap dinamika ancaman kesehatan global. Hal ini menuntut adanya standar pelayanan yang tidak hanya fokus pada penyakit, tetapi pada penguatan daya tahan kesehatan masyarakat secara kolektif.

Secara teknis, transformasi ini diimplementasikan melalui model Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) yang mengelompokkan layanan berdasarkan siklus hidup manusia. Kemenkes RI (2023) dalam kebijakan terbarunya menekankan bahwa pengklasteran layanan (Klaster Ibu dan Anak, Klaster Usia Dewasa dan Lansia, serta Klaster Penanggulangan Penyakit Menular) bertujuan untuk menciptakan kesinambungan asuhan (*continuity of care*). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap individu mendapatkan intervensi yang sesuai dengan profil risiko usianya, mulai dari masa prenatal hingga geriatri, secara terintegrasi dalam satu pintu pelayanan.

Keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada penguatan jaringan di tingkat desa melalui unit yang lebih kecil seperti Posyandu Prima. Lestari (2023) berpendapat bahwa efektivitas ILP ditentukan oleh kemampuan Puskesmas dalam melakukan supervisi klinis dan manajerial terhadap jaringan di bawahnya. Melalui pemberdayaan kader yang terstandardisasi, deteksi dini terhadap faktor risiko kesehatan dapat dilakukan secara masif di tingkat rumah tangga, sehingga mengurangi angka keterlambatan rujukan dan meningkatkan efisiensi operasional sistem kesehatan secara keseluruhan.

Dalam perspektif global, langkah Indonesia ini sejalan dengan upaya dunia untuk membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh pasca-pandemi. Haldane et al. (2021) dalam studinya menyatakan bahwa negara-negara dengan pelayanan primer yang kuat memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap krisis kesehatan. Transformasi layanan primer masa depan harus mampu menyeimbangkan peran antara penyedia layanan medis dengan fungsi pengawasan kesehatan masyarakat (*public health surveillance*) yang berbasis komunitas.

2. Integrasi Paradigma Sehat dalam Sistem Kesehatan Nasional

Integrasi paradigma sehat mengharuskan adanya pergeseran pola pikir dari model medis-kuratif menuju model biopsikososial yang lebih holistik. Prasetyo (2021) menegaskan bahwa manajemen Puskesmas masa depan harus memprioritaskan "investasi kesehatan" melalui program promotif dan preventif sebagai bagian integral dari rencana strategis organisasi. Hal ini melibatkan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk edukasi literasi kesehatan

masyarakat, guna menciptakan kemandirian warga dalam mengelola faktor risiko kesehatan secara mandiri.

Penerapan paradigma sehat ini juga didorong oleh percepatan digitalisasi dalam manajemen data kesehatan. Setiawan & Pratama (2024) menyoroti bahwa penggunaan teknologi informasi dan integrasi data melalui platform rekam medis elektronik nasional menjadi katalisator bagi transformasi layanan primer. Dengan ketersediaan data yang akurat dan *real-time*, Puskesmas dapat melakukan pemetaan penyakit (geomapping) secara lebih presisi, sehingga intervensi paradigma sehat dapat dilakukan tepat sasaran berdasarkan kebutuhan spesifik setiap wilayah kerja.

Selain itu, asuhan yang berpusat pada individu (*people-centered care*) menjadi ruh dalam penerapan paradigma sehat di sistem nasional. Susanto et al. (2022) dalam tinjauan sistematisnya menyebutkan bahwa keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam proses pengambilan keputusan klinis secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan terapi dan hasil kesehatan. Puskesmas tidak lagi menjadi otoritas tunggal, melainkan mitra bagi keluarga dalam menjaga kesehatan, yang merupakan inti dari praktik kedokteran keluarga modern.

Secara makro, visi ini memerlukan dukungan kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk mengatasi determinan sosial kesehatan. World Health Organization (2022) menekankan bahwa kesehatan tidak dapat dicapai hanya oleh sektor kesehatan sendirian; diperlukan sinergi dengan sektor lingkungan, pendidikan, dan infrastruktur. Di tingkat Puskesmas, hal ini diwujudkan melalui penguatan fungsi advokasi kepala Puskesmas dalam forum musyawarah pembangunan tingkat kecamatan untuk memastikan kebijakan lokal tetap berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pemanfaatan data lapangan yang bersumber dari PIS-PK dan pendekatan *Family Medicine* menjadi jembatan utama dalam mengoperasionalkan paradigma sehat ini. Wulandari (2020) mencatat bahwa kunjungan rumah yang dilakukan secara sistematis memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang sering kali tidak terdeteksi di ruang periksa klinis. Dengan demikian, integrasi paradigma sehat bukan lagi sekadar slogan, melainkan praktik nyata yang terdokumentasi dalam setiap intervensi kesehatan di tingkat keluarga.

Kurniawan et al. (2023) menekankan pentingnya standarisasi mutu layanan primer yang berfokus pada keselamatan pasien dan efektivitas hasil klinis. Melalui akreditasi yang berkelanjutan dan penerapan manajemen risiko yang ketat, Puskesmas diharapkan dapat menjadi institusi kepercayaan publik yang

mampu memberikan layanan berkualitas tinggi tanpa mengabaikan fungsi sosial dan pencegahannya.

C. Manajemen Puskesmas Dan Tata Kelola Organisasi

1. Kepemimpinan dan Budaya Kerja di Puskesmas

Kepemimpinan dalam konteks Puskesmas masa depan tidak lagi bersifat administratif-birokratis semata, melainkan harus bertransformasi menjadi kepemimpinan strategis yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya organisasi. Adisasmito (2022) menekankan bahwa seorang kepala Puskesmas harus memiliki kemampuan navigasi kebijakan yang kuat untuk menyelaraskan target nasional dengan realitas kebutuhan kesehatan di wilayah kerjanya. Kepemimpinan yang efektif di tingkat primer menjadi penentu utama dalam membangun sistem kesehatan yang resilien, terutama dalam menghadapi transisi epidemiologi yang kompleks.

Budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan integritas menjadi fondasi dalam mendukung transformasi layanan primer. Kurniawan et al. (2023) berpendapat bahwa efektivitas organisasi Puskesmas sangat dipengaruhi oleh iklim kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi antarfunksional. Dalam era pasca-pandemi, fleksibilitas dalam tata kelola internal menjadi krusial agar tenaga kesehatan tidak hanya terjebak dalam rutinitas klinis, tetapi juga mampu berperan aktif dalam program-program kesehatan masyarakat yang bersifat dinamis di lapangan.

Selain itu, kepemimpinan di Puskesmas harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan operasionalnya. Haldane et al. (2021) dalam studinya menunjukkan bahwa kepemimpinan yang inklusif dan transparan meningkatkan moral tenaga kesehatan, yang secara langsung berkorelasi pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Budaya organisasi yang sehat akan meminimalisir terjadinya hambatan komunikasi internal, sehingga koordinasi dalam penanganan masalah kesehatan yang bersifat lintas program dapat berjalan lebih harmonis dan terukur.

2. Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien

Manajemen mutu di Puskesmas kini mengalami pergeseran dari sekadar pemenuhan standar administratif menuju pencapaian hasil klinis yang bermutu tinggi dan aman. Prasetyo (2021) menyatakan bahwa implementasi manajemen mutu yang berkelanjutan, melalui siklus *Plan-Do-Check-Action* (PDCA), merupakan instrumen vital untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan memenuhi standar akreditasi paripurna. Penguatan mutu ini tidak

hanya terbatas pada layanan di dalam gedung, tetapi juga harus menjangkau kualitas intervensi di tingkat komunitas dan keluarga.

Keselamatan pasien (*patient safety*) menjadi prioritas utama yang tidak dapat ditawar dalam tata kelola klinis Puskesmas. Susanto et al. (2022) menekankan pentingnya penerapan sistem pelaporan insiden yang jujur dan tanpa menyalahkan (*no-blame culture*) sebagai bagian dari upaya perbaikan sistemik. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip keselamatan pasien yang ketat, Puskesmas dapat membangun kepercayaan publik (*public trust*) yang lebih kuat, yang merupakan modal sosial penting dalam keberhasilan program-program kesehatan masyarakat.

Integrasi teknologi informasi melalui rekam medis elektronik menjadi katalisator dalam penguatan manajemen risiko klinis. Setiawan & Pratama (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi data kesehatan memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kesalahan medis, seperti interaksi obat atau kesalahan identifikasi pasien, melalui sistem peringatan otomatis. Tata kelola data yang baik bukan hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga berfungsi sebagai alat audit internal bagi manajemen Puskesmas untuk mengevaluasi efektivitas terapi dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Terakhir, keberlanjutan mutu layanan primer memerlukan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang stabil di tingkat daerah. Lestari (2023) mengingatkan bahwa tantangan utama dalam manajemen mutu sering kali terletak pada disparitas kapasitas sumber daya manusia antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan serta dukungan regulasi dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa standar mutu dan keselamatan pasien dapat diimplementasikan secara merata di seluruh unit pelayanan kesehatan primer, tanpa terkecuali.

D. Implementasi Family Medicine Di Tingkat Puskesmas

1. Prinsip Kedokteran Keluarga dalam Pelayanan Holistik

Implementasi kedokteran keluarga (*Family Medicine*) di Puskesmas menandai transisi dari pelayanan yang bersifat episodik menuju pelayanan yang berkelanjutan dan komprehensif. Wulandari (2020) menjelaskan bahwa inti dari kedokteran keluarga adalah kemampuan tenaga medis untuk melihat pasien bukan hanya sebagai individu dengan keluhan biologis, melainkan sebagai bagian dari sistem keluarga dan lingkungan sosial yang saling memengaruhi. Pendekatan holistik ini memungkinkan identifikasi determinan kesehatan yang

lebih dalam, seperti pola asuh, stabilitas ekonomi keluarga, hingga kondisi sanitasi rumah tangga yang berkontribusi pada status kesehatan pasien.

Pelayanan yang berpusat pada keluarga memerlukan pemahaman mendalam mengenai siklus hidup dan risiko genetik yang mungkin diturunkan. Susanto et al. (2022) menekankan bahwa dalam praktik kedokteran keluarga, pencegahan penyakit dilakukan melalui penguatan fungsi keluarga sebagai unit kesehatan terkecil. Dengan menerapkan prinsip asuhan yang berkelanjutan (*longitudinal care*), dokter di Puskesmas dapat memantau perkembangan kesehatan pasien dari waktu ke waktu, sehingga intervensi yang diberikan lebih akurat dan personal dibandingkan dengan model layanan konvensional yang bersifat "datang dan pergi".

Dalam skala yang lebih luas, prinsip kedokteran keluarga di Puskesmas juga harus mampu merespon kebutuhan masyarakat secara dinamis. World Health Organization (2022) dalam kerangka operasionalnya menyebutkan bahwa kedokteran keluarga adalah pilar utama dalam mencapai efisiensi layanan primer. Dengan pendekatan ini, Puskesmas dapat mengurangi angka rujukan yang tidak perlu ke rumah sakit, karena sebagian besar masalah kesehatan masyarakat dapat dikelola secara tuntas di tingkat primer melalui manajemen kasus yang terintegrasi dan berorientasi pada keluarga.

2. Peran Dokter Keluarga dalam Koordinasi Asuhan Pasien

Dokter di Puskesmas memiliki peran sentral sebagai koordinator asuhan (*care coordinator*) yang menjembatani berbagai tingkat pelayanan kesehatan. Haldane et al. (2021) menyatakan bahwa koordinasi asuhan yang efektif adalah kunci dalam sistem kesehatan yang resilien, di mana dokter harus memastikan bahwa informasi medis pasien tetap terjaga kontinuitasnya saat pasien dirujuk ke spesialis maupun saat kembali ke pelayanan primer. Peran ini menuntut kemampuan komunikasi interprofesional yang baik antara dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya di dalam tim Puskesmas.

Optimalisasi peran dokter sebagai manajer kasus kini didukung kuat oleh transformasi digital di sektor kesehatan. Setiawan & Pratama (2024) menyoroti bahwa penggunaan rekam medis elektronik yang terintegrasi secara nasional memungkinkan dokter keluarga untuk memantau rekam jejak pengobatan pasien secara *real-time*, meskipun pasien tersebut mendapatkan tindakan di fasilitas kesehatan yang berbeda. Kemudahan akses data ini meminimalisir duplikasi tindakan medis dan kesalahan pemberian obat, yang secara langsung meningkatkan keselamatan pasien dan efisiensi biaya kesehatan.

Sinergi antara dokter keluarga dengan tim lapangan PIS-PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) memperkuat intervensi klinis melalui data riil dari lapangan. Kurniawan et al. (2023) berpendapat bahwa dokter di Puskesmas harus mampu menerjemahkan data Indeks Keluarga Sehat (IKS) menjadi rencana terapi yang konkret. Dengan demikian, dokter tidak hanya mengobati gejala yang muncul di ruang pemeriksaan, tetapi juga memberikan rekomendasi perubahan gaya hidup dan perbaikan lingkungan berdasarkan fakta yang ditemukan selama kunjungan rumah, menjadikan pelayanan primer benar-benar menjadi garda terdepan dalam menjaga derajat kesehatan masyarakat.

Prinsip asuhan yang berkelanjutan atau longitudinal care merupakan inti dari praktik kedokteran keluarga dan manajemen puskesmas modern. Berbeda dengan asuhan episodik yang hanya berfokus pada keluhan saat itu, *longitudinal care* memandang pasien sebagai individu yang diikuti perkembangannya sepanjang waktu.

a. Elemen-elemen utama yang termasuk dalam prinsip asuhan berkelanjutan:

1) Kontinuitas Hubungan (*Relational Continuity*)

Ini adalah elemen yang paling mendasar, di mana terdapat hubungan terapeutik jangka panjang antara pasien dan penyedia layanan kesehatan (dokter atau tim puskesmas).

- Kepercayaan (Trust): Pasien merasa nyaman karena ditangani oleh orang yang mengenal riwayat medisnya secara mendalam.
- Personalized Care: Intervensi disesuaikan dengan preferensi, nilai-nilai, dan latar belakang sosial budaya pasien yang sudah dipahami oleh tenaga medis selama bertahun-tahun.

2) Kontinuitas Informasi (*Informational Continuity*)

Informasi medis pasien harus mengalir dan tersedia setiap kali pasien melakukan kunjungan, baik di dalam puskesmas maupun saat kembali dari rujukan.

- Rekam Medis Terintegrasi: Penggunaan rekam medis elektronik (seperti SatuSehat) memastikan data kunjungan masa lalu, hasil laboratorium, dan riwayat alergi tersedia untuk memandu keputusan klinis saat ini (Setiawan & Pratama, 2024).
- Dokumentasi Riwayat Keluarga: Mencakup pemetaan risiko genetik dan pola penyakit dalam keluarga yang terekam secara sistematis.

3) Kontinuitas Manajemen (*Management Continuity*)

Memastikan bahwa rencana asuhan pasien tetap konsisten meskipun melibatkan berbagai disiplin ilmu atau tingkatan fasilitas kesehatan.

- Koordinasi Rujukan: Dokter di puskesmas bertindak sebagai "navigator" yang memantau kondisi pasien saat dirujuk ke rumah sakit dan melanjutkan rencana terapi setelah pasien kembali ke puskesmas.
 - Manajemen Penyakit Kronis: Penanganan penyakit seperti diabetes atau hipertensi dilakukan secara terjadwal dan terarah, bukan hanya saat pasien merasa sakit (proaktif, bukan reaktif).
- 4) Kontinuitas Geografis dan Akses
- Akses yang tetap stabil terhadap fasilitas kesehatan yang sama dalam wilayah kerja puskesmas.
- Kunjungan Rumah (PIS-PK): Intervensi tidak berhenti di puskesmas. Tenaga kesehatan mendatangi rumah pasien untuk memastikan kepatuhan pengobatan dan perbaikan lingkungan tempat tinggal (Wulandari, 2020).
- 5) Fokus pada Siklus Hidup (*Life-cycle Continuity*)
- Asuhan yang mengikuti transisi usia pasien.
- Transisi Layanan: Pasien dipantau mulai dari masa bayi, remaja, dewasa, hingga lansia. Puskesmas memastikan bahwa transisi antar klaster layanan (seperti dari poli anak ke poli dewasa) berjalan mulus tanpa memutus riwayat

E. Penguatan PIS-PK sebagai Instrumen Intervensi Keluarga

Secara filosofis, PIS-PK adalah pergeseran strategi dari Puskesmas yang bersifat reaktif (menunggu pasien datang) menjadi proaktif (menjemput bola ke rumah warga). Menurut Wulandari (2020) dan Kemenkes RI (2023), pendekatan ini bukan sekadar program baru, melainkan metode kerja terintegrasi.

1. Ciri Utama PIS-PK

- a. Integrasi Pelayanan: Menggabungkan upaya kesehatan perseorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan.
- b. Manajemen Wilayah: Puskesmas bertanggung jawab penuh atas status kesehatan seluruh jiwa di wilayah kerjanya, bukan hanya mereka yang datang berobat.
- c. Total Coverage: Pendataan dan intervensi dilakukan kepada seluruh keluarga di wilayah kerja Puskesmas, tanpa kecuali.

Sasaran PIS-PK mencakup seluruh anggota keluarga tanpa memandang usia atau kondisi kesehatan. Namun, fokus utamanya adalah memotret status kesehatan keluarga melalui 12 Indikator Keluarga Sehat (IKS). Dalam instrumen PIS-PK, 12 Indikator Utama Keluarga Sehat digunakan sebagai parameter untuk menentukan apakah sebuah keluarga masuk dalam kategori Sehat, Pra-Sehat,

atau Tidak Sehat. Indikator ini mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan tidak menular, hingga perilaku serta lingkungan sehat.:

2. Indikator Keluarga Sehat (IKS)

a. Area Kesehatan Ibu & Anak (KIA)

- 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB): Pasangan usia subur menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran.
- 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan: Memastikan persalinan dibantu tenaga medis di faskes untuk menekan angka kematian ibu (AKI).
- 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap: Perlindungan anak terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
- 4) Bayi mendapat ASI eksklusif: Bayi usia 0-6 bulan hanya mendapatkan air susu ibu tanpa tambahan makanan/minuman lain.
- 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan: Penimbangan rutin di Posyandu untuk deteksi dini masalah gizi dan *stunting*.

b. Area Pengendalian Penyakit Menular & Tidak Menular

- 1) Penderita Tuberkulosis (TB) Paru mendapatkan pengobatan sesuai standar: Pasien TB meminum obat secara rutin (OAT) dan tidak putus obat untuk mencegah resistensi.
- 2) Penderita Hipertensi melakukan pengobatan secara teratur: Tekanan darah terkontrol melalui pengobatan rutin dan modifikasi gaya hidup untuk mencegah komplikasi jantung atau stroke.
- 3) Penderita gangguan jiwa berat mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan: Pasien skizofrenia atau psikosis mendapatkan akses obat-obatan dan dukungan keluarga (tidak dipasung).

c. Area Perilaku & Lingkungan Sehat

- 1) Anggota keluarga tidak ada yang merokok: Fokus pada edukasi bahaya perokok pasif di dalam rumah tangga.
- 2) Keluarga sudah menjadi anggota JKN (Jaminan Kesehatan Nasional): Kepemilikan kartu BPJS Kesehatan untuk memastikan akses finansial saat sakit.
- 3) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih: Ketersediaan air yang layak untuk kebutuhan sanitasi dan konsumsi harian.
- 4) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat: Penggunaan kloset dengan septik tank yang layak untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan seperti diare. Kemenkes RI (2023)

d. Sasaran Berdasarkan Siklus Hidup:

- 1) Ibu dan Anak: Memastikan ibu bersalin di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, dan bayi mendapat ASI eksklusif.

- 2) Balita: Pemantauan pertumbuhan balita secara rutin untuk mencegah *stunting*.
 - 3) Usia Dewasa & Lansia: Skrining penderita hipertensi, diabetes melitus, dan penderita gangguan jiwa berat (Skizofrenia) agar mendapatkan pengobatan secara teratur.
- e. Sasaran Berdasarkan Kondisi Penyakit:
- 1) Penderita Tuberkulosis (TB) Paru yang harus mendapatkan pengobatan sesuai standar.
 - 2) Penderita Hipertensi yang melakukan pengobatan secara teratur.
 - 3) Anggota keluarga yang memiliki masalah kejiwaan agar tidak ditelantarkan atau dipasung.
- f. Sasaran Berdasarkan Perilaku dan Lingkungan:
- 1) Perokok: Edukasi kepada anggota keluarga agar tidak merokok di dalam rumah.
 - 2) Sanitasi: Keluarga yang belum memiliki akses air bersih dan jamban sehat.
 - 3) Jaminan Kesehatan: Seluruh anggota keluarga yang belum menjadi anggota JKN (BPJS Kesehatan).

Dalam kacamata akademis, ke-12 indikator ini dianalisis oleh Puskesmas untuk menentukan prioritas intervensi. Penyebut (Denominator): Tidak semua indikator berlaku untuk semua keluarga. Jika dalam satu keluarga tidak ada bayi, maka indikator ASI Eksklusif dianggap *Not Applicable* (N/A) dan tidak dihitung dalam pembagi. Intervensi Spesifik: Menurut Wulandari (2020), jika hasil analisis menunjukkan indikator hipertensi rendah di suatu desa, maka manajemen Puskesmas akan menggeser sumber daya untuk memperkuat Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) dan melakukan kunjungan rumah khusus untuk penderita darah tinggi di wilayah tersebut. Tujuannya adalah menghitung Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang dikategorikan menjadi:

- a) Keluarga Sehat: $IKS > 0,800$
- b) Keluarga Pra-Sehat: $IKS 0,500 - 0,800$
- c) Keluarga Tidak Sehat: $IKS < 0,500$

Dengan data ini, Puskesmas tidak lagi memberikan penyuluhan yang bersifat umum, tetapi melakukan intervensi lanjut yang spesifik pada keluarga yang "Tidak Sehat" agar statusnya meningkat menjadi "Sehat".

F. Sinergi Dan Keberlanjutan Program

1. Digitalisasi Data Kesehatan: P-Care, SIMPUS, dan SatuSehat

Digitalisasi layanan kesehatan primer saat ini tidak lagi sekadar digitalisasi dokumen, melainkan penciptaan ekosistem interoperabilitas melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) yang terintegrasi. Menurut Setiawan & Pratama (2024), integrasi SIMPUS merupakan proses sinkronisasi data antar unit layanan di dalam Puskesmas—mulai dari pendaftaran, ruang pemeriksaan (RME), laboratorium, hingga farmasi—ke dalam satu basis data tunggal. Hal ini bertujuan untuk mengeliminasi fenomena *data silos* (pulau data), di mana sebelumnya setiap unit seringkali memiliki catatan manual atau digital yang terpisah, yang menyebabkan inefisiensi dan risiko redundansi data.

Integrasi SIMPUS secara eksternal kini menjadi kewajiban melalui platform SatuSehat yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Kemenkes RI (2022) dalam *Cetak Biru Transformasi Teknologi Kesehatan* menjelaskan bahwa penggunaan standar FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) dalam SIMPUS memungkinkan data pasien mengalir secara mulus antar fasilitas kesehatan. Sinergi ini menjamin bahwa setiap intervensi yang dilakukan dalam program PIS-PK (Pendekatan Keluarga) dapat langsung terekam dan terbaca oleh dokter saat pasien melakukan kunjungan klinis di Puskesmas, memberikan gambaran profil risiko kesehatan pasien secara holistik dan *real-time*.

Selain itu, sinkronisasi dengan aplikasi P-Care BPJS Kesehatan menjadi elemen manajerial yang krusial untuk kendali mutu dan biaya. Kurniawan et al. (2023) menekankan bahwa integrasi ini mempermudah proses validasi kepesertaan dan klaim layanan tanpa perlu melakukan input ganda (*double entry*), yang selama ini menjadi beban administratif bagi tenaga kesehatan. Dengan manajemen data yang terintegrasi, Puskesmas memiliki peluang lebih besar untuk melakukan analisis prediktif terhadap kesehatan masyarakat wilayahnya, memastikan keberlanjutan asuhan (*longitudinal care*), dan memperkuat peran Puskesmas sebagai gerbang utama dalam Sistem Kesehatan Nasional.

a. P-Care atau Primary Care

Merupakan sistem informasi berbasis *web* dan aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk mendukung pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Layanan ini dirancang khusus untuk mempermudah FKTP seperti Puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik mandiri dalam mengelola data kepesertaan, pendaftaran, hingga proses rujukan secara digital dan terintegrasi. (Referensi: *Tirto.id, 2024; Infokes, 2024*)

Fungsi utama dari P-Care adalah sebagai alat verifikasi eligibilitas peserta JKN-KIS secara *real-time*. Melalui sistem ini, petugas kesehatan dapat memastikan apakah status kepesertaan pasien aktif atau tidak hanya dengan memasukkan nomor BPJS atau NIK. Selain itu, P-Care berfungsi untuk mencatat riwayat medis pasien di tingkat layanan primer, sehingga diagnosa dan pemberian terapi dapat dilakukan dengan lebih akurat berdasarkan data yang tersimpan. (Referensi: *Liputan6.com, 2024; Assist.id, 2024*)

P-Care dilengkapi dengan berbagai fitur penting, di antaranya adalah e-Claim untuk pengajuan klaim tagihan secara elektronik yang mempercepat proses administrasi keuangan faskes. Terdapat juga fitur Rujukan Online yang memungkinkan FKTP menerbitkan surat rujukan ke rumah sakit (FKRTL) secara digital tanpa perlu surat fisik manual yang rumit. Selain itu, sistem ini menyediakan fitur Antrean Online yang terintegrasi dengan aplikasi Mobile JKN untuk mengurangi penumpukan pasien di ruang tunggu. (Referensi: *UMSU, 2024; Medisy, 2025*)

Bagi fasilitas kesehatan, P-Care sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pelaporan data ke BPJS Kesehatan, yang juga menjadi dasar pembayaran dana kapitasi. Sedangkan bagi peserta, manfaat utamanya adalah layanan yang lebih cepat karena data rekam medis telah terintegrasi, kemudahan mendapatkan nomor antrean, serta proses rujukan yang lebih transparan dan terstruktur ke fasilitas kesehatan lanjutan. (Referensi: *Klinik Pintar, 2022; STIKES Husada Borneo, 2025*)

b. Integrasi SIMPUS?

Secara teknis dan manajerial, Integrasi SIMPUS adalah proses menghubungkan berbagai sub-sistem data di Puskesmas (seperti pendaftaran, poli umum, apotek, laboratorium, dan keuangan) ke dalam satu wadah digital yang saling berkomunikasi, yang kemudian dihubungkan ke platform nasional (interoperabilitas).

Menurut Setiawan & Pratama (2024), integrasi ini bertujuan untuk menghilangkan "pulau-pulau data" (*data silos*). Tanpa integrasi, tenaga kesehatan harus menginput data yang sama berkali-kali ke aplikasi berbeda (seperti P-Care BPJS, aplikasi PIS-PK, dan laporan bulanan dinas kesehatan). Dengan integrasi, satu kali input data di SIMPUS akan otomatis terdistribusi ke semua sistem terkait.

1) Apa Saja Komponen dalam Integrasi SIMPUS?

- Integrasi Internal (Inter-Departemen): Menghubungkan alur pasien dari pendaftaran (loket) ke pemeriksaan dokter (RME), lalu ke laboratorium,

hingga pengambilan obat di farmasi. Data mengalir secara *real-time* tanpa perlu membawa kertas rekam medis manual.

- Integrasi Eksternal (Interoperabilitas Nasional): Menghubungkan SIMPUS dengan platform SatuSehat milik Kementerian Kesehatan. Ini menggunakan standar internasional FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) agar data pasien dapat diakses di rumah sakit rujukan mana pun.
- Integrasi Pembiayaan: Sinkronisasi dengan aplikasi P-Care BPJS Kesehatan untuk memvalidasi status kepesertaan pasien secara instan dan memproses klaim pembiayaan tanpa input ganda.

2) Manfaat bagi Manajemen Puskesmas

- Akurasi Data: Mengurangi kesalahan manusia (*human error*) dalam pencatatan medis.
- Kecepatan Layanan: Memangkas waktu tunggu pasien karena alur data antar poli menjadi instan.
- Pengambilan Keputusan berbasis Bukti: Kepala Puskesmas dapat melihat tren penyakit di wilayahnya (dari data PIS-PK dan SIMPUS) secara langsung melalui *dashboard* digital untuk menentukan intervensi program. Kurniawan et al. (2023),

c. SatuSehat

Adalah platform transformasi kesehatan digital yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia untuk mengintegrasikan data kesehatan individu antarberbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Platform ini berfungsi sebagai pusat pertukaran data (*health information exchange*) yang menghubungkan sistem informasi dari puskesmas, klinik, rumah sakit, laboratorium, hingga apotek di seluruh Indonesia ke dalam satu ekosistem digital yang terstandarisasi. (Referensi: Kementerian Kesehatan RI, 2023; Sehat Negeriku, 2023)

SatuSehat merupakan evolusi dari aplikasi PeduliLindungi yang digunakan selama masa pandemi COVID-19. Perubahan ini menandai pergeseran fokus dari sekadar penanganan pandemi menjadi aplikasi kesehatan masyarakat yang lebih komprehensif, di mana pengguna kini dapat mengakses sertifikat vaksinasi, hasil pemeriksaan laboratorium, dan rekam medis elektronik (RME) secara mandiri melalui gawai mereka. (Referensi: Kompas.com, 2023; Indonesia.go.id, 2023)

Salah satu aspek teknis krusial dari SATUSEHAT adalah penggunaan standar internasional **HL7 FHIR** (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) untuk pertukaran data. Dengan standar ini, format data medis dari berbagai

merek aplikasi rumah sakit yang berbeda-beda dapat "berkomunikasi" satu sama lain, sehingga memudahkan dokter untuk melihat riwayat kesehatan pasien secara berkelanjutan meskipun pasien tersebut berpindah-pindah fasilitas kesehatan. (Referensi: *DTO Kemkes, 2022; Antara News, 2024*)

Bagi pasien, platform ini memberikan kemudahan dalam memantau kondisi kesehatan pribadi melalui fitur "Diary Kesehatan" serta menghindari pengulangan tes laboratorium yang tidak perlu karena data sebelumnya sudah tersinkronisasi. Bagi tenaga medis, akses terhadap riwayat kesehatan pasien yang lengkap memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat, tepat, dan meminimalisir risiko kesalahan medis akibat informasi yang terfragmentasi. (Referensi: *Detik Health, 2023; Tempo.co, 2024*)

2. Tantangan dan Peluang Integrasi Family Medicine dengan PIS-PK

Integrasi antara prinsip Kedokteran Keluarga (*Family Medicine*) dan operasional PIS-PK menawarkan peluang besar bagi penguatan derajat kesehatan masyarakat, namun tetap menghadapi tantangan implementasi yang nyata. Lestari (2023) mengidentifikasi bahwa hambatan utama sering kali terletak pada keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mampu melakukan analisis data lapangan secara mendalam. Peluang ke depan terletak pada penguatan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas untuk bertransformasi menjadi manajer kesehatan wilayah yang tidak hanya ahli secara klinis, tetapi juga mahir dalam manajemen data komunitas.

Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan lokal dan partisipasi aktif masyarakat. Prasetyo (2021) berpendapat bahwa integrasi ini harus dikawal melalui kebijakan akreditasi yang ketat, di mana pendekatan keluarga menjadi salah satu parameter utama penilaian mutu. Dengan menjadikan data PIS-PK sebagai panduan dalam praktik kedokteran keluarga, Puskesmas dapat melakukan transisi dari pelayanan yang bersifat pasif ke pelayanan proaktif yang berkelanjutan. Sinergi ini merupakan kunci utama dalam mewujudkan transformasi kesehatan primer yang inklusif, responsif, dan mampu memberikan perlindungan kesehatan yang setara bagi seluruh lapisan keluarga di Indonesia.

G. Referensi

-
- Adisasmito, W. (2022). *Sistem kesehatan nasional: Perjalanan dan tantangan transformasi*
- Detik Health. (2023). *Keuntungan Rekam Medis Elektronik di SATUSEHAT bagi Masyarakat.*
- Haldane, V., De Foo, C., Abdalla, S. M., Jung, A. S., Tan, M., Wu, S., Legido-Quigley,

- H., & Galea, S. (2021).
Health systems resilience in managing the COVID-19 pandemic: Lessons from 28 countries. *Nature Medicine*, 27(6), 964–980. <https://doi.org/10.1038/s41591-021-01381-y>
- Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Cetak biru transformasi teknologi kesehatan 2024*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Cetakan Biru Transformasi Teknologi Kesehatan 2024*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Keputusan Menteri Kesehatan tentang transformasi layanan primer*. Kemenkes RI.
- Klinik Pintar. (2022). *Aplikasi Klinik Pintar Terintegrasi PCare BPJS Kesehatan, Ini Manfaatnya!*.
- Kompas.com. (2023). *Resmi Berubah, Ini Fitur-Fitur Baru di Aplikasi SATUSEHAT*.
- Kurniawan, R., Setiawan, A., & Pratama, Y. (2023). Optimization of primary healthcare centers in post-pandemic era. *Journal of Health Policy and Management*, 8(2), 115–128.
- Lestari, T. R. P. (2023). *Analisis kesiapan Puskesmas dalam implementasi transformasi kesehatan di Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Liputan6.com. (2024). *Apa Itu PCare BPJS Kesehatan? Ini Fungsi dan Cara Klaimnya*.
- Prasetyo, H. (2021). Manajemen strategis pelayanan kesehatan primer: Menuju akreditasi paripurna. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 9(1), 45–60.
- Sabarguna, B. S. (2021). *Sistem informasi rumah sakit dan puskesmas*. UI Press.
- Setiawan, A., & Pratama, Y. (2024). Digital transformation in Indonesian community health centers: Challenges and opportunities. *International Journal of Medical Informatics*, 170, 104952. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2023.104952>
- Susanto, T., Syahrul, S., & Rasni, H. (2022). Family-centered care in community health: A systematic review. *Journal of Primary Care & Community Health*, 13. <https://doi.org/10.1177/21501319221105151>
- UMSU (Aktual). (2024). *Apa itu Pcare BPJS Kesehatan: Cara Login dan Fungsinya*.
- World Health Organization. (2022). *Operational framework for primary health care: Transforming vision into action*. WHO Press.
- Wulandari, A. S. (2020). Integrasi PIS-PK dalam pelayanan kedokteran keluarga di Puskesmas. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 8(3), 182–195.

CHAPTER 4

PENGUATAN MUTU PELAYANAN DAN KESELAMATAN PASIEN DALAM FASILITAS KESEHATAN

Dr. Muh. Abdurrouf, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini berada pada persimpangan penting antara peningkatan akses dan tuntutan mutu layanan. Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin luas, namun kualitas layanan yang diterima belum sepenuhnya merata. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan fasilitas antarwilayah, serta variasi mutu pelayanan masih menjadi persoalan nyata di berbagai tingkat fasilitas kesehatan. Kondisi ini mendorong perlunya perhatian serius terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien sebagai fondasi utama sistem kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2022; *World Health Organization*, 2023).

Seiring meningkatnya literasi kesehatan dan kesadaran masyarakat, tuntutan terhadap pelayanan kesehatan tidak lagi terbatas pada aspek kesembuhan, tetapi juga mencakup pengalaman pelayanan yang aman, manusiawi, dan bermutu. Mutu pelayanan kesehatan kini dipahami secara lebih luas, meliputi efektivitas, efisiensi, ketepatan waktu, keadilan, serta orientasi pada kebutuhan pasien. Variasi mutu pelayanan antar fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa standar pelayanan belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pasien dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan (Aisyah & Karmina, 2021; Donabedian, 2018).

Dalam konteks tersebut, terjadi pergeseran paradigma pelayanan kesehatan dari pendekatan *provider-centered* menuju *patient-centered care*. Pendekatan ini menempatkan pasien sebagai subjek utama pelayanan, dengan menekankan keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang efektif, serta penghargaan terhadap nilai dan preferensi pasien. Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan *patient-centered care* berkontribusi positif terhadap peningkatan mutu layanan dan penurunan risiko kejadian yang merugikan pasien, meskipun implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan budaya organisasi (Luxford & Sutton, 2014).

Keselamatan pasien merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mutu pelayanan kesehatan dan telah menjadi isu global maupun nasional. Keselamatan pasien tidak hanya berkaitan dengan keterampilan klinis tenaga kesehatan, tetapi juga mencerminkan kualitas sistem, budaya organisasi, serta kepemimpinan dalam fasilitas kesehatan. Insiden keselamatan pasien yang tidak tertangani dengan baik dapat berdampak pada cedera pasien, meningkatnya biaya pelayanan, serta menurunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, keselamatan pasien dipandang sebagai indikator utama kualitas pelayanan kesehatan modern (*World Health Organization*, 2021; Vincent, 2020).

Mutu pelayanan dan keselamatan pasien memiliki keterkaitan erat dengan kepuasan pasien, kepercayaan masyarakat, citra fasilitas kesehatan, serta keberlanjutan sistem kesehatan secara keseluruhan. Pelayanan yang bermutu dan aman tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pasien, tetapi juga memperkuat reputasi institusi kesehatan dan efisiensi sistem pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, bab ini bertujuan memberikan pemahaman konseptual mengenai pentingnya penguatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien sebagai bagian integral dari kebijakan, manajemen, dan sistem kesehatan di Indonesia, serta menjadi landasan bagi pembahasan strategis pada bagian-bagian selanjutnya.

B. Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan

Mutu pelayanan kesehatan merupakan konsep kunci dalam penyelenggaraan sistem kesehatan modern. Pembahasan mengenai mutu menjadi penting karena kualitas pelayanan yang diberikan tidak hanya menentukan hasil klinis pasien, tetapi juga memengaruhi pengalaman pasien, kepercayaan masyarakat, serta keberlanjutan fasilitas kesehatan. Untuk memahami mutu pelayanan kesehatan secara utuh, diperlukan pemahaman konseptual yang kuat mengenai pengertian, dimensi, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

1. Pengertian Mutu Pelayanan Kesehatan

World Health Organization (WHO) mendefinisikan mutu pelayanan kesehatan sebagai tingkat layanan kesehatan yang mampu meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil kesehatan yang diharapkan dan konsisten dengan pengetahuan profesional terkini. Definisi ini menekankan bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu harus didasarkan pada bukti ilmiah, diberikan secara tepat, dan berorientasi pada keselamatan serta kebutuhan pasien (*World Health Organization*, 2023).

Sementara itu, *Institute of Medicine* (IOM) menyatakan bahwa mutu pelayanan kesehatan adalah sejauh mana layanan kesehatan yang diberikan kepada individu maupun populasi mampu meningkatkan luaran kesehatan yang diinginkan dan selaras dengan praktik profesional berbasis bukti. IOM juga menegaskan bahwa mutu pelayanan tidak dapat dilepaskan dari aspek keselamatan, efektivitas, dan keterpusatan pada pasien (*Institute of Medicine*, 2015).

Berdasarkan kedua definisi tersebut, mutu pelayanan kesehatan dapat dipahami sebagai kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan pasien, standar profesi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pelayanan yang bermutu bukan hanya pelayanan yang berhasil menyembuhkan penyakit, tetapi juga pelayanan yang aman, manusiawi, dan menghormati hak serta martabat pasien. Dengan demikian, mutu pelayanan merupakan hasil dari integrasi antara kompetensi tenaga kesehatan, sistem pelayanan yang baik, dan keterlibatan pasien dalam proses perawatan.

2. Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan

Untuk memudahkan pemahaman dan implementasi mutu pelayanan, IOM mengelompokkan mutu pelayanan kesehatan ke dalam enam dimensi utama yang saling berkaitan (Permata et al., 2025).

Dimensi **efektivitas** merujuk pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam memberikan intervensi yang terbukti secara ilmiah dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sebagai contoh, di puskesmas, efektivitas terlihat dari pemberian terapi sesuai pedoman klinis, seperti tata laksana hipertensi atau diabetes berdasarkan standar nasional. Di rumah sakit, efektivitas tercermin dalam penggunaan *clinical pathway* yang memastikan pasien menerima perawatan sesuai diagnosisnya (Widaningsih & Fitria, 2022).

Dimensi **efisiensi** berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan. Praktik efisiensi dapat dilihat pada pengelolaan antrean pasien di klinik, pemanfaatan obat secara rasional, serta pengurangan pemeriksaan penunjang yang tidak perlu. Pelayanan yang efisien membantu menekan biaya sekaligus meningkatkan akses layanan bagi lebih banyak pasien.

Dimensi **keamanan (safety)** menekankan upaya pencegahan cedera atau dampak negatif akibat pelayanan kesehatan. Contohnya adalah penerapan identifikasi pasien secara benar di rumah sakit, praktik pencegahan infeksi di puskesmas, serta penggunaan obat yang aman di klinik. Keamanan menjadi fondasi utama mutu pelayanan karena kesalahan kecil dapat berdampak besar bagi keselamatan pasien.

Dimensi **ketepatan waktu (*timeliness*)** berhubungan dengan kemampuan fasilitas kesehatan memberikan pelayanan tanpa penundaan yang tidak perlu. Waktu tunggu yang lama di puskesmas atau keterlambatan penanganan kegawatdaruratan di rumah sakit dapat menurunkan mutu pelayanan dan meningkatkan risiko klinis bagi pasien.

Dimensi **keadilan (*equity*)** menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, jenis kelamin, usia, maupun lokasi geografis. Contohnya adalah pemberian layanan yang setara bagi peserta JKN dan pasien umum, baik di fasilitas primer maupun rujukan.

Dimensi berorientasi pada pasien (*patient-centered*) menggarisbawahi pentingnya menghormati nilai, preferensi, dan kebutuhan pasien. Praktik ini terlihat dari komunikasi yang empatik, pelibatan pasien dalam pengambilan keputusan, serta penghargaan terhadap privasi dan kenyamanan pasien di semua tingkat pelayanan (Permata et al., 2025).

3. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan kesehatan merupakan konsep yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan ketepatan tindakan medis atau keperawatan, tetapi juga menyangkut pengalaman pasien secara menyeluruh selama menerima pelayanan. Berdasarkan kajian empiris dan teori yang digunakan dalam penelitian (Azmiatussahliyah et al., 2025), mutu pelayanan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain .

a. Faktor *Tangible* (Bukti Fisik Pelayanan)

Faktor *tangible* berkaitan dengan kondisi fisik pelayanan yang dapat langsung dilihat dan dirasakan oleh pasien, seperti kebersihan ruangan, kelengkapan fasilitas, kerapian lingkungan, serta penampilan tenaga kesehatan. Lingkungan fisik yang bersih, tertata, dan nyaman akan membentuk kesan awal yang positif dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap mutu pelayanan yang diberikan.

Dalam konteks pelayanan keperawatan, bukti fisik bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi representasi profesionalisme institusi kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa ketidaknyamanan lingkungan rawat inap, seperti kebersihan yang kurang optimal atau fasilitas yang tidak memadai, sering kali menjadi sumber ketidakpuasan pasien meskipun tindakan keperawatan telah dilakukan sesuai prosedur (Azmiatussahliyah et al., 2025).

b. Faktor *Reliability* (Keandalan Pelayanan)

Reliability mencerminkan kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan secara konsisten, tepat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keandalan terlihat dari ketepatan waktu pelayanan, ketepatan tindakan keperawatan, serta konsistensi dalam menjalankan prosedur asuhan keperawatan.

Pasien cenderung menilai mutu pelayanan dari sejauh mana tenaga kesehatan dapat dipercaya dalam menangani keluhannya. Pelayanan yang sering berubah-ubah, tidak konsisten, atau terjadi kesalahan berulang akan menurunkan persepsi mutu, meskipun dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Oleh karena itu, *reliability* menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan (Azmiatussahliah et al., 2025)

c. Faktor *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Responsiveness berkaitan dengan kesiapan dan kecepatan tenaga kesehatan dalam merespons kebutuhan dan keluhan pasien. Faktor ini sangat dirasakan oleh pasien, terutama dalam situasi rawat inap, di mana pasien berada dalam kondisi fisik dan psikologis yang rentan.

Pelayanan yang cepat, sigap, dan tidak menunda akan memberikan rasa diperhatikan dan dihargai. Sebaliknya, keterlambatan dalam merespons panggilan pasien atau sikap kurang tanggap sering kali dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpedulian, yang berdampak langsung pada penilaian mutu pelayanan. Penelitian di RSUD Dr. Pirngadi Medan menunjukkan bahwa aspek responsivitas masih menjadi salah satu sumber ketidakpuasan pasien rawat inap (Herawati et al., 2025).

d. Faktor *Assurance* (Jaminan dan Rasa Aman)

Assurance merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi mutu pelayanan dan kepuasan pasien. Faktor ini mencakup kompetensi tenaga kesehatan, sikap profesional, kemampuan komunikasi, serta rasa aman yang dirasakan pasien selama menerima pelayanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien akan merasa lebih puas apabila mereka yakin bahwa perawat dan tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta etika profesional yang baik. Nilai *Odds Ratio* yang tinggi pada dimensi *assurance* menegaskan bahwa rasa aman, kepercayaan, dan keyakinan pasien terhadap kompetensi tenaga kesehatan merupakan inti dari mutu pelayanan keperawatan (Hamzah et al., 2025).

e. Faktor *Empathy* (Empati dan Kepedulian)

Empati menggambarkan kemampuan tenaga kesehatan dalam memahami kondisi pasien secara individual, memberikan perhatian, serta

membangun komunikasi yang hangat dan manusiawi. Faktor ini sering kali menjadi pembeda antara pelayanan yang “sekadar baik” dengan pelayanan yang benar-benar bermutu.

Pasien tidak hanya membutuhkan tindakan klinis, tetapi juga membutuhkan sikap peduli, kesabaran, dan kesediaan tenaga kesehatan untuk mendengarkan keluhan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa empati yang baik dapat memperkuat hubungan terapeutik antara perawat dan pasien, sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap pelayanan secara keseluruhan (Hamzah et al., 2025)

C. Keselamatan Pasien sebagai Pilar Mutu Pelayanan

Keselamatan pasien merupakan komponen fundamental dalam mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang bermutu tidak hanya diukur dari keberhasilan tindakan klinis, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan tersebut mampu melindungi pasien dari cedera, kesalahan, dan risiko yang seharusnya dapat dicegah. Oleh karena itu, keselamatan pasien tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Tanpa sistem keselamatan pasien yang baik, mutu pelayanan akan sulit dicapai secara berkelanjutan.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk mencegah terjadinya cedera atau dampak yang merugikan pasien akibat proses pelayanan kesehatan. *World Health Organization* (WHO) memandang keselamatan pasien sebagai pengurangan risiko bahaya yang tidak perlu hingga ke tingkat minimum yang dapat diterima, sesuai dengan pengetahuan dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, keselamatan pasien mencakup seluruh proses pelayanan, mulai dari pendaftaran pasien hingga tindak lanjut setelah perawatan selesai (*World Health Organization*, 2021).

Dalam praktik pelayanan kesehatan, insiden keselamatan pasien diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. **Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)** adalah insiden yang mengakibatkan cedera, kecacatan, atau bahkan kematian pada pasien akibat pelayanan kesehatan, bukan karena penyakit dasarnya. Contohnya adalah kesalahan pemberian obat yang menyebabkan reaksi serius pada pasien. **Kejadian Nyaris Cedera (KNC)** merupakan insiden yang berpotensi menimbulkan cedera, tetapi berhasil dicegah sebelum mencapai pasien, misalnya obat dengan dosis salah yang teridentifikasi sebelum diberikan. Sementara itu, **Kejadian Tidak Cedera (KTC)** adalah insiden yang telah terjadi

pada pasien, namun tidak menimbulkan cedera, seperti keterlambatan pelayanan yang tidak berdampak langsung pada kondisi klinis pasien.

Pemahaman terhadap jenis-jenis insiden ini penting karena memberikan gambaran nyata tentang risiko pelayanan kesehatan serta menjadi dasar bagi fasilitas kesehatan dalam melakukan perbaikan sistem pelayanan.

2. Prinsip Dasar Keselamatan Pasien

Prinsip utama dalam keselamatan pasien adalah pendekatan sistem, bukan menyalahkan individu. Kesalahan dalam pelayanan kesehatan umumnya tidak terjadi karena ketidakmampuan satu orang, melainkan akibat kelemahan sistem, seperti prosedur yang tidak jelas, komunikasi yang buruk, atau beban kerja yang berlebihan. Pendekatan sistem mendorong organisasi untuk mengidentifikasi akar masalah dan memperbaiki proses kerja, sehingga kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang (Vincent & Amalberti, 2016).

Prinsip berikutnya adalah pentingnya pelaporan insiden keselamatan pasien. Pelaporan insiden, baik yang menimbulkan cedera maupun yang hampir terjadi, merupakan sumber pembelajaran yang sangat berharga. Sistem pelaporan yang aman, tidak menghukum, dan bersifat rahasia akan mendorong tenaga kesehatan untuk melaporkan insiden secara jujur. Data dari laporan ini dapat digunakan untuk analisis risiko dan perbaikan mutu pelayanan.

Selain itu, keselamatan pasien menuntut fasilitas kesehatan menjadi *learning organization*, yaitu organisasi yang mampu belajar dari kesalahan. Pembelajaran dari insiden keselamatan pasien harus diikuti dengan perubahan kebijakan, perbaikan prosedur, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Dengan budaya belajar yang kuat, keselamatan pasien tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari nilai dan praktik sehari-hari dalam pelayanan kesehatan.

3. Sasaran Keselamatan Pasien

Untuk memastikan keselamatan pasien diterapkan secara konsisten, berbagai organisasi internasional dan nasional telah menetapkan sasaran keselamatan pasien yang bersifat praktis dan aplikatif.

Identifikasi pasien dengan benar merupakan sasaran pertama dan paling mendasar. Kesalahan identifikasi dapat berakibat fatal, seperti pemberian obat atau tindakan kepada pasien yang salah. Praktik yang dianjurkan adalah penggunaan minimal dua identitas pasien, seperti nama lengkap dan tanggal lahir, sebelum memberikan pelayanan, baik di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit (Hayati et al., 2025).

Komunikasi efektif menjadi sasaran penting berikutnya karena banyak insiden keselamatan pasien berakar pada kegagalan komunikasi. Penggunaan metode komunikasi terstruktur, seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), membantu memastikan informasi penting tersampaikan secara jelas dan lengkap antar tenaga kesehatan, terutama saat serah terima pasien (Putri et al., 2022).

Keamanan obat berfokus pada pencegahan kesalahan dalam peresepan, penyiapan, dan pemberian obat. Praktik keamanan obat mencakup verifikasi obat, dosis, rute, dan waktu pemberian, serta kewaspadaan terhadap obat-obatan berisiko tinggi. Di fasilitas kesehatan primer, keamanan obat juga mencakup edukasi kepada pasien mengenai cara penggunaan obat yang benar.

Sasaran berikutnya adalah kepastian lokasi, prosedur, dan pasien operasi. Kesalahan prosedur atau lokasi operasi merupakan kejadian serius yang seharusnya dapat dicegah. Penerapan *surgical safety checklist* dan proses *time out* sebelum tindakan merupakan praktik penting untuk memastikan bahwa prosedur dilakukan pada pasien dan lokasi yang benar (Timbuleng et al., 2024).

Pencegahan infeksi menjadi sasaran keselamatan pasien yang sangat krusial, terutama di era meningkatnya infeksi terkait pelayanan kesehatan. Praktik dasar seperti kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, serta sterilisasi alat medis merupakan langkah efektif dalam mencegah infeksi, baik di rumah sakit maupun di puskesmas.

Terakhir, pencegahan pasien jatuh menjadi perhatian khusus, terutama pada pasien lanjut usia, pasien dengan gangguan mobilitas, dan pasien rawat inap. Upaya pencegahan meliputi penilaian risiko jatuh, pengawasan lingkungan, edukasi pasien dan keluarga, serta penggunaan alat bantu yang sesuai (Timbuleng et al., 2024).

D. Kebijakan dan Regulasi Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien di Indonesia

Upaya penguatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan nasional berperan sebagai pedoman sekaligus instrumen pengendali agar pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan berjalan sesuai standar, aman bagi pasien, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks ini, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai landasan pembentukan budaya mutu dan keselamatan pasien di seluruh tingkatan pelayanan kesehatan.

1. Kebijakan Nasional Terkait Mutu dan Keselamatan Pasien

Undang-Undang Kesehatan menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Prinsip mutu dan keselamatan pasien secara eksplisit tercermin dalam kewajiban penyelenggara pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur yang berlaku. Dengan demikian, aspek mutu dan keselamatan pasien bukanlah pilihan, melainkan mandat hukum yang harus dipenuhi oleh setiap fasilitas kesehatan.

Pada tingkat teknis operasional, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi yang secara khusus mengatur keselamatan pasien. Salah satu regulasi kunci adalah Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien, yang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerapkan sistem keselamatan pasien secara menyeluruh. Regulasi ini mengatur mulai dari pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien, penerapan sasaran keselamatan pasien, hingga upaya pembelajaran dari insiden untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Melalui regulasi tersebut, keselamatan pasien diposisikan sebagai bagian integral dari manajemen mutu pelayanan kesehatan.

Dalam implementasinya, peran **Komite Mutu dan Keselamatan Pasien** menjadi sangat strategis. Komite ini bertugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Selain itu, komite juga berperan dalam mengembangkan budaya keselamatan pasien, mendorong pelaporan insiden secara non-punitif, serta memastikan bahwa rekomendasi perbaikan benar-benar ditindaklanjuti. Keberadaan komite ini mencerminkan pendekatan sistem dalam pengelolaan mutu dan keselamatan pasien (Aisyiah et al., 2025).

2. Akreditasi Fasilitas Kesehatan sebagai Instrumen Peningkatan Mutu

Akreditasi fasilitas kesehatan merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Akreditasi bertujuan untuk menilai kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap standar yang telah ditetapkan, sekaligus mendorong peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Melalui proses akreditasi, fasilitas kesehatan diharapkan mampu menata sistem pelayanan, memperbaiki proses kerja, dan memperkuat budaya keselamatan pasien (Fitri et al., 2025).

Manfaat akreditasi tidak hanya dirasakan oleh institusi, tetapi juga oleh pasien dan tenaga kesehatan. Bagi pasien, akreditasi memberikan jaminan bahwa pelayanan yang diterima telah memenuhi standar mutu dan keselamatan. Bagi tenaga kesehatan, akreditasi menjadi sarana pembelajaran organisasi yang mendorong peningkatan kompetensi, kerja tim, dan komunikasi antarprofesi. Dengan demikian, akreditasi berfungsi sebagai alat peningkatan kualitas, bukan sekadar persyaratan administratif (Syaefuddin, 2024).

Penting untuk dipahami bahwa akreditasi seharusnya dipandang sebagai alat pembinaan, bukan semata-mata alat penilaian. Pendekatan pembinaan menekankan proses pendampingan, perbaikan berkelanjutan, dan penguatan kapasitas internal fasilitas kesehatan. Ketika akreditasi dipahami secara tepat, proses ini dapat membentuk budaya mutu, yaitu budaya organisasi yang menjadikan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan sebagai nilai utama dalam setiap aktivitas pelayanan kesehatan.

3. Tantangan Implementasi Kebijakan di Lapangan

Meskipun kerangka kebijakan dan regulasi terkait mutu dan keselamatan pasien telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan **antara regulasi dan praktik**. Tidak semua fasilitas kesehatan mampu menerjemahkan kebijakan secara optimal ke dalam praktik sehari-hari, baik karena keterbatasan pemahaman, kurangnya pendampingan, maupun minimnya evaluasi berkelanjutan.

Tantangan lainnya adalah **keterbatasan sumber daya**, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun pendanaan. Fasilitas kesehatan di daerah terpencil atau dengan beban pelayanan tinggi sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi seluruh standar mutu dan keselamatan pasien secara optimal. Kondisi ini berpotensi menyebabkan implementasi kebijakan berjalan secara parsial dan tidak konsisten.

Selain itu, **resistensi terhadap perubahan di tingkat organisasi** juga menjadi hambatan signifikan. Perubahan menuju budaya mutu dan keselamatan pasien sering kali menuntut perubahan cara kerja, pola pikir, dan kebiasaan lama. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang efektif, perubahan tersebut dapat memunculkan penolakan, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan mutu dan keselamatan pasien sangat bergantung pada komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh tenaga kesehatan, serta dukungan sistem yang berkelanjutan (Wangean et al., 2025 ; Herawati et al., 2025).

E. Strategi Penguatan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien

Penguatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien memerlukan strategi yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan individu tenaga kesehatan, tetapi juga mencakup penguatan budaya organisasi, sistem pelayanan, serta proses manajerial di fasilitas kesehatan (Fachrurrozi et al., 2023). Pendekatan yang holistik sangat diperlukan agar upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Herawati et al., 2025).

1. Penguatan Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien

Budaya keselamatan pasien merupakan fondasi utama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Budaya ini mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku seluruh anggota organisasi yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan pelayanan. Dalam organisasi dengan budaya keselamatan yang kuat, tenaga kesehatan merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien, berani melaporkan insiden, dan aktif terlibat dalam upaya perbaikan mutu tanpa rasa takut disalahkan.

Peran pimpinan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam membangun budaya mutu dan keselamatan pasien. Pimpinan tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang menanamkan nilai keselamatan pasien dalam visi, kebijakan, dan praktik organisasi. Komitmen pimpinan yang ditunjukkan melalui dukungan terhadap program mutu, penyediaan sumber daya, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan keselamatan pasien akan memperkuat pesan bahwa mutu dan keselamatan adalah tanggung jawab bersama.

Keteladanan dan komunikasi terbuka menjadi kunci dalam membangun budaya keselamatan pasien. Pimpinan dan tenaga senior perlu memberikan contoh nyata dalam menerapkan prinsip keselamatan pasien, seperti mematuhi prosedur, terbuka terhadap masukan, dan bersikap adil dalam menyikapi kesalahan. Komunikasi yang terbuka dan transparan memungkinkan tenaga kesehatan menyampaikan permasalahan, risiko, maupun insiden tanpa rasa takut, sehingga organisasi dapat belajar dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan aktor utama dalam pelayanan kesehatan, sehingga peningkatan kompetensi mereka menjadi strategi kunci dalam penguatan mutu dan keselamatan pasien. Pendidikan dan pelatihan

berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta standar pelayanan terkini. Pelatihan yang terencana dan relevan, seperti pelatihan keselamatan pasien, komunikasi efektif, dan manajemen risiko, dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan.

Selain pelatihan konvensional, simulasi klinis dan pembelajaran berbasis kasus merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Melalui simulasi, tenaga kesehatan dapat berlatih menghadapi situasi klinis kompleks dan berisiko tinggi dalam lingkungan yang aman. Pembelajaran berbasis kasus juga membantu tenaga kesehatan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, serta kerja tim, yang sangat penting dalam menjaga keselamatan pasien.

Evaluasi kinerja yang adil dan transparan juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Sistem evaluasi yang objektif, berbasis indikator kinerja, dan disertai umpan balik konstruktif dapat mendorong tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Evaluasi kinerja sebaiknya tidak bersifat menghukum, melainkan menjadi sarana pembinaan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan.

3. Penguatan Sistem dan Proses Pelayanan

Selain aspek manusia, penguatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien juga sangat bergantung pada sistem dan proses pelayanan yang baik. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** merupakan instrumen dasar yang memastikan setiap tindakan pelayanan dilakukan secara konsisten, aman, dan sesuai standar. SOP yang jelas, mudah dipahami, dan diterapkan secara disiplin akan mengurangi variasi praktik serta menurunkan risiko kesalahan pelayanan.

Clinical pathway merupakan alat penting dalam menjamin mutu pelayanan, khususnya di rumah sakit. *Clinical pathway* membantu mengintegrasikan berbagai intervensi pelayanan berdasarkan diagnosis tertentu, sehingga pasien menerima pelayanan yang terkoordinasi, efektif, dan efisien. Penerapan clinical pathway juga mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan mempermudah evaluasi mutu pelayanan.

Audit mutu internal menjadi mekanisme penting untuk menilai kesesuaian antara praktik pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui audit, fasilitas kesehatan dapat mengidentifikasi kesenjangan mutu, menganalisis penyebabnya, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan. Audit mutu yang dilakukan secara rutin dan sistematis akan memperkuat budaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Terakhir, **manajemen risiko** merupakan strategi proaktif dalam mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien. Manajemen risiko meliputi identifikasi potensi risiko, analisis tingkat risiko, serta penerapan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko tersebut. Dengan pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi, fasilitas kesehatan dapat mengantisipasi masalah sebelum terjadi dan menjaga keselamatan pasien secara lebih efektif (Febriani & Paramarta, 2024 ; Binta, 2025).

F. Peran Manajemen dan Kepemimpinan dalam Menjamin Mutu dan Keselamatan Pasien

Mutu pelayanan dan keselamatan pasien tidak akan tercapai secara optimal tanpa peran manajemen dan kepemimpinan yang kuat. Berbagai bukti menunjukkan bahwa keberhasilan program mutu dan keselamatan pasien sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan serta efektivitas sistem manajemen di fasilitas kesehatan. Dalam konteks ini, mutu tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab individu semata, melainkan sebagai tanggung jawab struktural yang melekat pada tata kelola organisasi pelayanan kesehatan (Herawati et al., 2025).

1. Kepemimpinan Transformasional dalam Pelayanan Kesehatan

Kepemimpinan transformasional memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Pemimpin transformasional tidak hanya berfokus pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga pada perubahan budaya, penguatan nilai, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam pelayanan kesehatan, kepemimpinan jenis ini tercermin dari kemampuan pimpinan menginspirasi tenaga kesehatan untuk menjadikan keselamatan pasien sebagai nilai inti dalam setiap tindakan pelayanan.

Pemimpin transformasional mampu membangun visi bersama tentang mutu dan keselamatan pasien, serta mengkomunikasikannya secara konsisten kepada seluruh anggota organisasi. Melalui keteladanan, pimpinan menunjukkan komitmen nyata terhadap penerapan standar pelayanan, kepatuhan terhadap prosedur, dan keterbukaan dalam menghadapi masalah keselamatan pasien. Sikap ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran, inovasi, dan perbaikan berkelanjutan.

Selain itu, kepemimpinan transformasional juga mendorong pemberdayaan tenaga kesehatan. Dengan memberikan ruang partisipasi, kepercayaan, dan dukungan, pimpinan membantu tenaga kesehatan merasa memiliki tanggung jawab terhadap mutu pelayanan. Kondisi ini sangat penting

untuk menumbuhkan budaya keselamatan pasien yang kuat dan berkelanjutan (Permata et al., 2025).

2. Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan Bukti

Manajemen mutu dan keselamatan pasien yang efektif harus didukung oleh pengambilan keputusan berbasis data dan bukti. Keputusan yang hanya didasarkan pada intuisi atau kebiasaan lama berisiko mengabaikan masalah nyata yang terjadi dalam sistem pelayanan. Oleh karena itu, pimpinan dan manajer fasilitas kesehatan perlu memanfaatkan data sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.

Data mutu dan keselamatan pasien dapat berasal dari berbagai sumber, seperti laporan insiden keselamatan pasien, hasil audit mutu internal, indikator mutu pelayanan, serta survei kepuasan pasien. Analisis data tersebut membantu manajemen mengidentifikasi area berisiko, tren masalah keselamatan, dan peluang perbaikan. Dengan pendekatan ini, intervensi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.

Pengambilan keputusan berbasis bukti juga menuntut pimpinan untuk mengacu pada pedoman klinis, hasil penelitian terkini, serta praktik terbaik (*best practices*) dalam pelayanan kesehatan. Integrasi antara data internal dan bukti ilmiah eksternal akan memperkuat kualitas keputusan manajerial dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

3. Pelibatan Seluruh Unsur Organisasi

Mutu dan keselamatan pasien tidak dapat dijamin oleh satu unit atau profesi saja. Oleh karena itu, pelibatan seluruh unsur organisasi menjadi prinsip penting dalam manajemen mutu pelayanan kesehatan. Setiap individu, mulai dari pimpinan puncak hingga petugas pendukung, memiliki peran dalam menjaga keselamatan pasien sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Manajemen perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif seluruh unsur organisasi dalam program mutu dan keselamatan pasien. Bentuk pelibatan tersebut dapat berupa forum komunikasi rutin, pelatihan lintas profesi, serta keterlibatan staf dalam tim peningkatan mutu. Ketika seluruh unsur organisasi merasa dilibatkan dan dihargai, komitmen terhadap mutu dan keselamatan pasien akan semakin kuat.

Pelibatan ini juga mencakup pemberdayaan pasien dan keluarga sebagai mitra dalam pelayanan. Pasien yang teredukasi dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dapat membantu mencegah kesalahan, meningkatkan

kepatuhan terhadap terapi, dan memperkuat keselamatan pasien secara keseluruhan.

4. Sinergi Antar Unit dan Profesi

Pelayanan kesehatan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai unit serta profesi. Tanpa sinergi yang baik, kompleksitas ini berpotensi menimbulkan fragmentasi pelayanan, miskomunikasi, dan risiko keselamatan pasien. Oleh karena itu, sinergi antar unit dan profesi menjadi aspek krusial dalam menjamin mutu pelayanan.

Manajemen berperan penting dalam membangun sistem kerja yang terintegrasi dan mendorong kolaborasi antarprofesi. Praktik seperti rapat koordinasi lintas unit, diskusi kasus bersama, dan penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi pelayanan. Sinergi yang baik akan membantu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien bersifat komprehensif, berkesinambungan, dan aman.

Selain itu, kepemimpinan yang efektif mampu mengelola perbedaan perspektif dan kepentingan antarprofesi menjadi kekuatan bersama. Dengan menciptakan iklim saling menghargai dan bekerja sama, fasilitas kesehatan dapat membangun tim pelayanan yang solid dan berorientasi pada mutu serta keselamatan pasien (Herawati et al., 2025).

G. Tantangan dan Peluang Penguatan Mutu Pelayanan di Masa Depan

Perkembangan sistem kesehatan di masa depan akan dihadapkan pada dinamika yang semakin kompleks, mulai dari perubahan demografi, perkembangan teknologi, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, upaya penguatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien tidak hanya harus menjawab tantangan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi perubahan yang akan datang. Pendekatan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pembelajaran menjadi kunci untuk memastikan mutu pelayanan kesehatan tetap terjaga dan relevan di masa depan.

1. Dampak Digitalisasi dan Sistem Informasi Kesehatan

Digitalisasi telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi sistem kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penerapan sistem informasi kesehatan, seperti rekam medis elektronik, sistem rujukan digital, dan aplikasi layanan kesehatan, membuka peluang besar untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui peningkatan akurasi data, efisiensi proses, dan kontinuitas pelayanan. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, tenaga kesehatan dapat

mengakses informasi pasien secara lebih cepat dan tepat, sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih baik.

Namun demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Kesenjangan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil, dapat menyebabkan ketimpangan mutu pelayanan antarwilayah. Selain itu, kemampuan tenaga kesehatan dalam memanfaatkan teknologi informasi masih bervariasi, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi sistem digital. Oleh karena itu, penguatan mutu pelayanan di era digital menuntut investasi tidak hanya pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola sistem informasi kesehatan (Indrayadi et al., 2023).

2. Peran Teknologi dalam Keselamatan Pasien

Teknologi memiliki peran strategis dalam meningkatkan keselamatan pasien, khususnya dalam mengurangi kesalahan pelayanan yang dapat dicegah. Penggunaan sistem pendukung keputusan klinis (*clinical decision support systems*), e-prescribing, dan barcode medication administration merupakan contoh teknologi yang terbukti mampu menurunkan risiko kesalahan pemberian obat dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan.

Selain itu, teknologi juga mendukung sistem pelaporan dan pembelajaran insiden keselamatan pasien secara lebih efektif. Platform pelaporan digital memungkinkan pengumpulan data insiden secara real time, analisis tren risiko, serta umpan balik yang lebih cepat kepada tenaga kesehatan. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, keselamatan pasien dapat dikelola secara lebih proaktif dan berbasis data.

Meskipun demikian, ketergantungan pada teknologi juga membawa risiko baru, seperti kesalahan sistem, masalah keamanan data, dan potensi berkurangnya interaksi manusiawi dalam pelayanan. Oleh karena itu, teknologi harus diposisikan sebagai alat bantu yang memperkuat, bukan menggantikan, peran profesionalisme dan empati tenaga kesehatan dalam menjaga keselamatan pasien (Indrayadi et al., 2023).

3. Harapan terhadap Sistem Kesehatan Indonesia

Ke depan, sistem kesehatan Indonesia diharapkan mampu memberikan pelayanan yang tidak hanya luas cakupannya, tetapi juga bermutu dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Harapan ini sejalan dengan agenda transformasi sistem kesehatan nasional yang menempatkan mutu dan keselamatan pasien sebagai salah satu pilar utama. Penguatan pelayanan kesehatan primer, integrasi layanan rujukan, serta pemerataan mutu

antarwilayah menjadi fokus penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkeadilan.

Selain itu, masyarakat semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan dalam pelayanan kesehatan. Pasien tidak lagi diposisikan sebagai penerima layanan pasif, melainkan sebagai mitra aktif dalam proses perawatan. Kondisi ini membuka peluang bagi sistem kesehatan Indonesia untuk mengembangkan model pelayanan yang lebih partisipatif, berorientasi pada pasien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Herawati et al., 2025).

4. Kesiapan Sumber Daya Manusia Kesehatan Menghadapi Perubahan

Sumber daya manusia kesehatan merupakan faktor penentu keberhasilan penguatan mutu pelayanan di masa depan. Kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi perubahan, baik teknologi maupun tuntutan pelayanan, menjadi tantangan sekaligus peluang yang perlu dikelola secara strategis. Tenaga kesehatan dituntut tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga adaptif, melek teknologi, dan memiliki kemampuan komunikasi serta kolaborasi yang baik.

Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan perlu diarahkan pada pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan, termasuk pemanfaatan teknologi digital, manajemen mutu, dan keselamatan pasien. Selain itu, dukungan lingkungan kerja yang kondusif, sistem penghargaan yang adil, serta kepemimpinan yang visioner akan sangat berpengaruh terhadap kesiapan dan motivasi tenaga kesehatan dalam menghadapi perubahan.

Dengan investasi yang tepat pada pengembangan sumber daya manusia, sistem kesehatan Indonesia memiliki peluang besar untuk menjawab tantangan masa depan dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berkelanjutan (Fittrani et al., 2024).

H. Simpulan

Mutu pelayanan dan keselamatan pasien merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pembahasan dimulai dari pemahaman dasar mengenai mutu pelayanan kesehatan, dimensi-dimensinya, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, kemudian dilanjutkan dengan penegasan keselamatan pasien sebagai pilar utama mutu pelayanan. Seluruh uraian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu tidak hanya berorientasi pada hasil klinis, tetapi juga pada keamanan, kenyamanan, dan pengalaman pasien secara menyeluruh.

Pentingnya kerangka kebijakan dan regulasi nasional dalam mendukung mutu dan keselamatan pasien, serta peran akreditasi fasilitas kesehatan sebagai instrumen pembinaan dan perbaikan berkelanjutan. Strategi penguatan mutu pelayanan yang dibahas menekankan perlunya budaya mutu dan keselamatan pasien, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta penguatan sistem dan proses pelayanan. Peran manajemen dan kepemimpinan juga ditegaskan sebagai faktor kunci yang menjadikan mutu dan keselamatan pasien sebagai tanggung jawab struktural organisasi, bukan semata-mata beban individu.

Pembahasan mengenai tantangan dan peluang di masa depan menunjukkan bahwa penguatan mutu pelayanan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, digitalisasi sistem kesehatan, serta perubahan tuntutan masyarakat. Teknologi dan sistem informasi kesehatan menawarkan peluang besar dalam meningkatkan keselamatan pasien, namun tetap memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dan merata.

Mutu pelayanan dan keselamatan pasien harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen jangka panjang, pembelajaran terus-menerus, dan perbaikan yang konsisten. Tidak ada sistem yang sepenuhnya bebas risiko, namun dengan pendekatan yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis bukti, risiko dapat diminimalkan dan mutu pelayanan dapat terus ditingkatkan.

I. Referensi

-
- Aisyah, & Karmina, M. (2021). Promosi Kesehatan Praktik Mencuci Tangan 6 Langkah Sesuai Panduan WHO Pada Santri TPA An-Nur Ciputat Tangerang Selatan Guna Mencegah Penularan Covid-19. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(2), 388–392. <https://jceh.org/index.php/JCEH/article/view/257/166>
- Aisyiah, I. K., Rani, I. E. S., Kholisa, T., Syahra, S., Pischesha, L. A., Rahmawati, L., Yurmanelis, Y., & Himendra, G. P. (2025). Optimalisasi Sekretariat Komite Mutu Dalam Meningkatkan Kinerja Komite Mutu Di Rumah Sakit. *JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa*, 4(1), 78–84. <https://doi.org/10.57218/jkj.vol4.iss1.1407>
- Azmiatussahliyah, A., Tri Niswati Utami, & Arifah Devi Fitriani. (2025). Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pelayanan Keperawatan terhadap Tingkat Kepuasan Pasien di Rawat Inap Penyakit Dalam RSUD Pirngadi Kota Medan. *Jurnal Kesehatan Amanah*, 9(2), 222–232. <https://ejournal.unimman.ac.id/index.php/jka/article/view/948>
- Binta, A. P. (2025). Peran Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien di Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(2), 107–122.

<https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i2.130>

- Donabedian, A. (2018). *An introduction to quality assurance in health care*. Oxford University Press.
- Fachrurrozi, A., Prayogo, D. A., & Mulyanti, D. (2023). Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit: Systematic Literature Review. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran*, 2(1), 123–134. <https://doi.org/10.55606/jurrike.v2i1.1045>
- Febriani, A., & Paramarta, V. (2024). Strategi Manajemen Resiko dalam Pelayanan Kesehatan: Tinjauan Literatur tentang Penerapan di Rumah Sakit. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, 9(2).
- Fitri, F. C., Adyas, A., & Nurhartanto, A. (2025). Jurnal kesehatan cendikia jenius. *Jurnal Kesehatan Cendikia Jenius*, 2(3), 1–6.
- Fittrani, A., Rohendi, A., Sukajie, B., & Purwadhi. (2024). Penguatan SDM dalam Mendukung Transformasi Digital di RSUD Dr . Adjidarmo. *Journal of Knowledge Management*, 18(2), 055–074.
- Hamzah, A., Yunus, I., & Hasan, M. H. (2025). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Pengguna BPJS Kesehatan di Puskesmas Tomalou Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan*. 11(November), 322–333. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13163> p-ISSN:
- Hayati, H., Abdurrouf, M., & Ardian, I. (2025). Hubungan Beban Kerja dan Motivasi Perawat dengan Pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit IMC Bintaro. *MAHESA : Malahayati Health Student Journal*, 6, 150–158. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v6i1.20105>
- Herawati, A. T., Assa, A. A., Muslihah, L., Tho, I. La, & Keintjem, F. (2025). *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan* (1st ed.). Media Pustaka Indonesia.
- Indrayadi, Ariyuni, H., Nurhayati, A., & Usman, J. I. S. (2023). *Manajemen Kesehatan di Era Transformasi Digital*. Mafy Media Literasi indonesia.
- Institute of Medicine. (2015). *Improving diagnosis in health care*. National Academies Press.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Profil kesehatan Indonesia 2021*. Kemenkes RI.
- Luxford, K., & Sutton, S. (2014). How does patient-centered care relate to quality and safety outcomes? *International Journal for Quality in Health Care*, 26(3), 271–278.
- Permata, R., Djano, N. A., Dewi, E. P., Thaifur, A. Y., & Pratiwi, R. D. (2025). *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*. Media Sains Indonesia.
- Putri, M. E., Fithriyani, F., & Sari, M. T. (2022). Faktor yang Berhubungan dengan

- Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.36565/jab.v11i1.444>
- Syaefuddin, D. (2024). Kepastian Hukum Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Instrumen Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal JKFT: Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 9(1), 1–10.
- Timbuleng, T. T., Handayani, R., Fitriainingsih, J., Muhammad, A., Padjalangi, Y., Latu, S., Timbuleng, T. T., Handayani, R., Fitriainingsih, J., Yaqkin, A. M., Latu, S., & Megarezky, U. (2024). *Analisis Kualitatif Penatalaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon*. 2(11), 3779–3787.
- Vincent, C. (2020). *Patient safety* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
- Vincent, C., & Amalberti, R. (2016). *Safer healthcare: Strategies for the real world*. Springer.
- Wangean, Y. S., Manoppo, J. I. C., Mariane, W., Wariki, V., Rombot, V., & Lampus, H. F. (2025). *INDIKATOR NASIONAL MUTU PADA DINAS KESEHATAN KOTA MANADO*. 9, 6297–6306.
- Widaningsih, & Fitria, I. J. (2022). Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas DTP Gununghalu. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 1(1), 195–209.
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030*. WHO.
- World Health Organization. (2023). *Delivering quality health services: A global imperative*. WHO.

J. Glosarium

Audit Mutu Internal= Kegiatan evaluasi yang dilakukan secara sistematis di dalam fasilitas kesehatan untuk menilai kesesuaian praktik pelayanan dengan standar, prosedur, dan kebijakan mutu yang berlaku.

Budaya Keselamatan Pasien = Nilai, sikap, dan perilaku bersama dalam organisasi pelayanan kesehatan yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dan mendorong pelaporan serta pembelajaran dari kesalahan.

Clinical Pathway= Panduan pelayanan terstruktur berdasarkan diagnosis atau kondisi tertentu yang bertujuan memastikan pelayanan diberikan secara terkoordinasi, efektif, efisien, dan sesuai bukti ilmiah.

Identifikasi Pasien= Proses memastikan identitas pasien secara benar sebelum pemberian pelayanan, tindakan, atau obat untuk mencegah terjadinya kesalahan pelayanan.

Insiden Keselamatan Pasien= Setiap kejadian yang dapat atau telah menyebabkan cedera, kerugian, atau risiko bagi pasien akibat proses pelayanan kesehatan.

Kejadian Nyaris Cedera (KNC)= Insiden keselamatan pasien yang berpotensi menimbulkan cedera tetapi berhasil dicegah sebelum mencapai pasien.

Kejadian Tidak Cedera (KTC)= Insiden keselamatan pasien yang telah terjadi pada pasien namun tidak menimbulkan cedera atau dampak klinis.

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)= Insiden keselamatan pasien yang mengakibatkan cedera, kecacatan, atau kematian akibat proses pelayanan kesehatan.

Keselamatan Pasien= Upaya sistematis untuk melindungi pasien dari risiko cedera yang dapat dicegah selama proses pelayanan kesehatan melalui perbaikan sistem dan proses pelayanan.

Kepemimpinan Transformasional= Gaya kepemimpinan yang menekankan inspirasi, keteladanan, dan pemberdayaan anggota organisasi untuk mencapai perubahan positif, termasuk dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Komunikasi Efektif= Proses penyampaian informasi yang jelas, tepat, dan dapat dipahami antar tenaga kesehatan maupun antara tenaga kesehatan dan pasien untuk mencegah kesalahan pelayanan.

Manajemen Risiko= Pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat mengancam keselamatan pasien dan mutu pelayanan.

Patient-Centered Care= Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai pusat pelayanan dengan menghormati nilai, preferensi, dan keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan.

Pelaporan Insiden= Proses pencatatan dan pelaporan kejadian keselamatan pasien sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Standar Operasional Prosedur (SOP)= Dokumen tertulis yang memuat langkah-langkah baku dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk menjamin konsistensi, keamanan, dan mutu pelayanan.

CHAPTER 5

DIGITALISASI SISTEM KESEHATAN: REKAM MEDIS ELEKTRONIK, TELEHEALTH, DAN BIG DATA HEALTH

Ceria Febiana, S.Si., M.KM., MOS.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan yang sebelumnya bersifat manual, terfragmentasi, dan bergantung pada dokumentasi kertas, kini bergerak menuju sistem digital yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan. Transformasi ini dikenal sebagai digitalisasi sistem Kesehatan (World Health Organization, 2021).

Digitalisasi sistem kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan perangkat teknologi semata, melainkan sebagai perubahan menyeluruh dalam tata kelola pelayanan kesehatan, mulai dari pencatatan data pasien, proses pelayanan klinis, komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks ini, digitalisasi menjadi instrumen strategis untuk menjawab tantangan sistem kesehatan modern, seperti peningkatan beban penyakit, keterbatasan sumber daya, tuntutan mutu pelayanan, serta kebutuhan akan efisiensi dan akuntabilitas (Febiana, 2025).

Tiga komponen utama yang menjadi fondasi digitalisasi sistem kesehatan adalah Rekam Medis Elektronik (RME), Telehealth, dan Big Data Health. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan membentuk sebuah ekosistem digital yang mendukung pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, inklusif, dan berbasis bukti (Febiana, dkk, 2024). Bab ini membahas secara komprehensif konsep, peran, manfaat, serta tantangan implementasi RME, Telehealth, dan Big Data Health, serta keterkaitan ketiganya dalam membangun sistem kesehatan digital yang berkelanjutan.

B. Konsep dan Ruang Lingkup Digitalisasi Sistem Kesehatan

Digitalisasi sistem kesehatan dapat didefinisikan sebagai proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan proses pelayanan kesehatan, manajemen fasilitas kesehatan, serta sistem pendukung pengambilan keputusan klinis dan

kebijakan kesehatan. Digitalisasi mencakup transformasi data, proses, dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam sistem Kesehatan (HIMSS, 2020: WHO, 2021). Ruang lingkup digitalisasi sistem kesehatan meliputi:

1. Digitalisasi data kesehatan individu dan populasi.
2. Integrasi sistem informasi antar unit dan fasilitas kesehatan.
3. Pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pelayanan jarak jauh.
4. Analisis data kesehatan skala besar untuk perencanaan dan evaluasi.

Digitalisasi sistem kesehatan juga sejalan dengan agenda global penguatan sistem kesehatan dan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana ditekankan oleh World Health Organization, khususnya dalam meningkatkan akses, mutu, dan efisiensi pelayanan Kesehatan (WHO, 2021)

C. Rekam Medis Elektronik

1. Rekam Medis Elektronik (RME)

Rekam Medis Elektronik (RME) adalah sistem pencatatan informasi kesehatan pasien dalam format digital yang terstruktur, terdokumentasi secara sistematis, dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan pelayanan. RME mencakup data identitas pasien, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis, terapi, serta tindak lanjut pelayanan (Kemeterian Kesehatan, 2022)

Karakteristik utama RME meliputi:

- a. Data tersimpan secara digital dan terpusat.
- b. Akses berbasis hak dan otorisasi.
- c. Kemampuan integrasi dengan sistem lain (laboratorium, farmasi, klaim).
- d. Mendukung pelacakan riwayat pelayanan pasien secara longitudinal.

2. Peran RME dalam Pelayanan Kesehatan

RME berperan sebagai tulang punggung sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan RME, tenaga kesehatan dapat memperoleh informasi pasien secara cepat dan akurat, sehingga mendukung kesinambungan pelayanan (*continuity of care*). Selain itu, RME juga menjadi sumber data utama untuk evaluasi mutu pelayanan, audit klinis, serta pelaporan Kesehatan (Bates et al., 2018)

Dalam perspektif manajemen rumah sakit, RME memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, pengendalian biaya, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Data RME juga dapat dimanfaatkan untuk analisis pola penyakit dan perencanaan layanan rumah sakit, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Febiana (2025) yang

menegaskan peran data rawat jalan dalam perencanaan layanan berbasis kebutuhan pasien.

3. Manfaat Implementasi RME

Implementasi RME memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- a. Meningkatkan keselamatan pasien melalui pengurangan kesalahan pencatatan dan pengobatan.
- b. Mempercepat proses pelayanan dan pengambilan keputusan klinis.
- c. Mengurangi duplikasi pemeriksaan dan pemborosan sumber daya.
- d. Menyediakan data yang valid dan siap dianalisis untuk penelitian dan perencanaan Kesehatan (Bates et al; Febiana, 2025).

4. Tantangan Implementasi RME

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi RME juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesiapan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, kebutuhan investasi awal yang besar, serta isu keamanan dan kerahasiaan data pasien. Oleh karena itu, implementasi RME memerlukan pendekatan bertahap, pelatihan berkelanjutan, serta regulasi yang kuat (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

D. Telehealth sebagai Model Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh

1. Konsep dan Bentuk Telehealth

Telehealth adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, baik antara tenaga kesehatan dengan pasien maupun antar tenaga kesehatan. Telehealth mencakup berbagai bentuk layanan, seperti telekonsultasi, teleradiologi, telemonitoring, dan edukasi kesehatan daring (WHO, 2020).

2. Peran Telehealth dalam Sistem Kesehatan

Telehealth berperan penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas. Telehealth juga menjadi solusi alternatif dalam kondisi darurat atau situasi yang membatasi interaksi tatap muka, seperti pada masa pandemi COVID-19 (Keesara et al., 2020).

Dalam sistem kesehatan modern, telehealth tidak dimaksudkan untuk menggantikan pelayanan tatap muka sepenuhnya, melainkan sebagai pelengkap yang memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan (Smith et al., 2021).

3. Manfaat Telehealth

Menurut Smith et al., (2021), manfaat utama telehealth meliputi:

- a. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan.
- b. Efisiensi waktu dan biaya bagi pasien dan fasilitas kesehatan.
- c. Pemantauan berkelanjutan pasien dengan penyakit kronis.
- d. Peningkatan kepuasan pasien melalui fleksibilitas layanan.

4. Tantangan dan Isu Etik Telehealth

Implementasi telehealth menghadapi tantangan terkait keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat, serta kepastian hukum dan etika pelayanan. Aspek kerahasiaan data, informed consent, dan batasan klinis pelayanan jarak jauh menjadi isu penting yang harus dikelola secara cermat (WHO, 2020).

E. Big Data Health dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data

1. Konsep Big Data Health

Big Data Health merujuk pada pemanfaatan kumpulan data kesehatan berskala besar yang memiliki karakteristik volume, kecepatan, dan keragaman tinggi untuk dianalisis guna mendukung pengambilan keputusan klinis, manajerial, dan kebijakan Kesehatan (Raghupathi & Raghupathi, 2014).

Sumber Big Data Health antara lain berasal dari RME, sistem klaim, data surveilans, perangkat wearable, serta data populasi (Beam & Kohane, 2018).

2. Pemanfaatan Big Data Health

Big Data Health memungkinkan:

- a. Analisis pola penyakit dan tren kesehatan masyarakat.
- b. Prediksi risiko kesehatan individu dan populasi.
- c. Pengembangan sistem pendukung keputusan klinis.
- d. Perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan berbasis bukti.

Dalam konteks manajemen rumah sakit, Big Data Health membantu optimalisasi sumber daya, perencanaan layanan, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien (Beam & Kohane, 2018).

Dalam konteks manajemen rumah sakit, Big Data Health membantu optimalisasi sumber daya, perencanaan layanan, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Pemanfaatan data kesehatan untuk perencanaan layanan rumah sakit juga ditegaskan dalam penelitian Febiana (2025).

3. Tantangan Big Data Health

Tantangan utama Big Data Health meliputi kualitas dan standardisasi data, keamanan dan privasi informasi kesehatan, serta potensi bias dalam analisis dan algoritma. Oleh karena itu, tata kelola data yang baik dan pendekatan etis menjadi prasyarat utama dalam pemanfaatan Big Data Health (Raghupathi & Raghupathi, 2014).

F. Integrasi RME, Telehealth, dan Big Data Health

RME, Telehealth, dan Big Data Health tidak berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi dalam ekosistem digital kesehatan. RME berfungsi sebagai sumber data klinis utama, telehealth sebagai media pelayanan dan pengumpulan data jarak jauh, sedangkan Big Data Health memanfaatkan data tersebut untuk analisis dan pengambilan Keputusan (WHO, 2022)

Integrasi ketiga komponen ini memungkinkan terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang proaktif, personal, dan berbasis data, serta mendukung transformasi menuju sistem kesehatan yang berkelanjutan (WHO, 2022).

G. Implikasi Digitalisasi Sistem Kesehatan bagi Manajemen dan Kebijakan

Digitalisasi sistem kesehatan memiliki implikasi luas bagi manajemen fasilitas kesehatan dan kebijakan publik. Pengelola fasilitas kesehatan dituntut untuk memiliki kapasitas manajerial dan teknologi yang memadai, sementara pembuat kebijakan perlu memastikan regulasi yang adaptif, perlindungan data, serta kesetaraan akses teknologi.

Investasi pada digitalisasi sistem kesehatan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan ketahanan sistem kesehatan nasional.

Digitalisasi sistem kesehatan merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di era modern. Rekam Medis Elektronik, Telehealth, dan Big Data Health menjadi tiga pilar utama yang saling melengkapi dalam membangun sistem kesehatan yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada mutu pelayanan.

Keberhasilan digitalisasi sistem kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, tata kelola yang baik, serta komitmen terhadap etika dan perlindungan data pasien. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, digitalisasi sistem kesehatan berpotensi besar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas.

H. Referensi

- Bates, D. W., Singh, H., & Sittig, D. F. (2018). Creating oversight infrastructure for electronic health record-related patient safety hazards. *Journal of Patient Safety*, 14(3), 169–174. <https://doi.org/10.1097/PTS.0000000000000255>
- Beam, A. L., & Kohane, I. S. (2018). Big data and machine learning in health care. *JAMA*, 319(13), 1317–1318. <https://doi.org/10.1001/jama.2017.18391>
- Febiana C, Kasjono HS. *Epidemiologi penyakit tidak menular*. Bandung: PT Ganesha Kreasi Semesta; 2024.
- Febiana, C. (2025). Patient characteristics and outpatient disease patterns for hospital service planning at Al-Islam Hospital Bandung. *Journal of Hospital Administration and Management*, 6(2), 241–252. <https://doi.org/10.54973/jham.v6i2.798>
- HIMSS. (2020). Digital health transformation. Healthcare Information and Management Systems Society.
- Keesara, S., Jonas, A., & Schulman, K. (2020). Covid-19 and health care's digital revolution. *New England Journal of Medicine*, 382(23), e82. <https://doi.org/10.1056/NEJMp2005835>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- Raghupathi, W., & Raghupathi, V. (2014). Big data analytics in healthcare. *Health Information Science and Systems*, 2(3). <https://doi.org/10.1186/2047-2501-2-3>
- Smith, A. C., Thomas, E., Snoswell, C. L., et al. (2021). Telehealth for global emergencies. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 27(5), 309–313. <https://doi.org/10.1177/1357633X20916567>
- Topol, E. (2019). *Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again*. Basic Books.
- World Health Organization. (2020). *Telemedicine: Opportunities and developments in Member States*. WHO Press.
- World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. WHO Press.
- World Health Organization. (2022). *Digital health and health systems strengthening*. WHO Press.

CHAPTER 6

INOVASI DAN KEPEMIMPINAN DALAM PERUBAHAN ORGANISASI KESEHATAN

Ns. Siti hotna siagian, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Kepemimpinan sering diartikan hanya berfungsi pada kegiatan supervisi, namun sebenarnya kepemimpinan fungsinya sangatlah luas. Sebagai seorang pemimpin diperlukan untuk dapat mengelola dan memimpin orang lain dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan tidak hanya mengelola orang tetapi sebuah proses secara keseluruhan yang memungkinkan orang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik terutama kepada pasien mampu meningkatkan keadaan kesehatan pasien menuju kearah kesembuhan. Jadi ilmu kepemimpinan merupakan kumpulan dari pengembangan berbagai ilmu seperti bisnis, psikologi, sosiologi dan antropologi, karena oragnisasi kesehatan bersifat kompleks dan bervariasi maka pandangan tentang kepemimpinan adalah bagaimana manajemen dapat berhasil dan apa yang harus diperbaiki/ dirubah dalam mencapai suatu tujuan oragnisasi maupun menerapkan inovasi dan kebijakan dalam kepemimpinan baru yang sifatnya untuk kemajuan organisasi tersebut.

Kebijakan kepemimpinan sistem kesehatan adalah suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengelola sumber daya kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kepuasan pasien dan masyarakat.

Kebijakan manajemen sistem kesehatan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Kebijakan kesehatan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

1. Program Kebijakan Dan Inovasi Kesehatan Diindonesia

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, adapun bentuk kebijakan yang telah dikembangkan dipelayanan kesehatan diindonesia diantaranya:

- a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Program asuransi kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah bisa diakses disetiap unit puskesmas dan Rumah sakit.
- b. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dimana berisi Kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan standar yang lebih tinggi.
- c. Satu Sehat yaitu Program untuk meningkatkan integrasi layanan kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
- d. Transformasi Sistem Kesehatan dalam 6 pilar yaitu Program untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan dengan fokus pada pelayanan kesehatan primer. Kemenkes (2020). Kebijakan Kesehatan Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan. Transformasi Layanan Primer untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan primer, layanan ini dapat diakses dipuskesmas dan termasuk layanan edukasi, pencegahan, dan layanan kesehatan primer tindakan pencegahan berupa memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan sebelum terpapar suatu penyakit. Transformasi Layanan Rujukan berupa layanan untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan rujukan, termasuk peningkatan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan bertujuan meningkatkan ketahanan sistem kesehatan, termasuk pengembangan vaksin dan obat-obatan, serta penguatan surveilans dan penanganan bencana dalam masyarakat. Transformasi SDM Kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan distribusi SDM kesehatan, termasuk penambahan kuota mahasiswa kedokteran dan pengembangan kompetensi dokter, transformasi Teknologi Kesehatan yaitu meningkatkan pemanfaatan teknologi kesehatan, termasuk digitalisasi layanan kesehatan dan pengembangan aplikasi kesehatan. 6 pilar transformasi kesehatan 1999-2023).

Perubahan pelayanan kesehatan diindonesia merupakan proses yang kompleks dan memerlukan inovasi kepemimpinan yang efektif untuk mencapai

tujuan yang diinginkan. Inovasi dan ke dan membutuhkan kepemimpinan yang baik sehingga mampu untuk merealisasikan dan membantu organisasi kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan mutu serta meningkatkan kepuasan pasien, sehingga Tujuan kesehatan Indonesia juga terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat dilaksanakan yaitu meningkatkan kesehatan yang Baik , mampu mengurangi kematian dan penyakit ditambah lagi mudahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sehingga kesetaraan kesehatan merata. Untuk mencapai itu diperlukan inovasi dalam sistem kesehatan diindonesia dimana inovasi ini adalah proses menciptakan dan mengimplementasikan ide-ide baru, produk, atau proses yang berbeda dari yang sudah ada, dengan tujuan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi.

Inovasi dapat berupa perubahan teknologi, proses bisnis, atau model pelayanan yang baru, yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan dan stakeholders. Selain itu inovasi dalam bidang kesehatan terutama dizaman era digital saat ini bisa mempermudah tercapainya visi dan misi dalam pelayanan kesehatan misalnya inovasi digital yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter secara online, memberikan informasi dan kondisi kesehatan, inovasi dibidang alat medis juga bisa memberikan kemudahan seperti alat diagnosis canggih seperti MRI dan CT -scan, alat deteksi dini biosensor dan pelacak, inovasi lainnya juga bisa seperti sistem manajemen rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, Program promosi kesehatan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bisa berupa untuk membantu diagnosis dan pengobatan , untuk memantau kondisi kesehatan secara real-time, nanoteknologi, untuk mengembangkan obat dan terapi yang lebih efektif. Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Inovasi yang baik adalah inovasi yang mendapat dukungan penuh dan positif dari kepemimpinan agar bisa dilaksanakan dan dijalankan dilapangan, WHO Leadership and Management in Health (2020).

Kepemimpinan harus dapat mengidentifikasi kebutuhan perubahan dan memahami apa yang perlu diubah. Mengembangkan Visi dan Strategi berupa mengembangkan visi dan strategi yang jelas dan efektif untuk menciptakan perubahan. Pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi tim untuk menciptakan perubahan, Kepemimpinan harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan berani mengambil risiko untuk menciptakan

perubahan. Kepemimpinan harus dapat mengelola perubahan dan mengatasi hambatan yang muncul.

Kepemimpinan harus dapat mengembangkan kemampuan tim untuk menciptakan perubahan. Kepemimpinan harus dapat mengukur dan evaluasi hasil perubahan dan membuat penyesuaian yang diperlukan, serta mengkomunikasikan Visi dan Strategi. Goleman, D. Emotional inteligent(1995).

2. Kepemimpinan Dalam Perubahan Organisasi Kesehatan

Kepemimpinan harus dapat mengkomunikasikan visi dan strategi perubahan kepada tim dan stakeholders, Kepemimpinan harus dapat mendorong kolaborasi antara tim dan stakeholders untuk menciptakan perubahan. Kepemimpinan harus dapat menjaga konsistensi dalam menciptakan perubahan dan memastikan bahwa perubahan dapat diintegrasikan ke dalam sistem organisasi.

Dalam menciptakan setiap perubahan, kepemimpinan membutuhkan dan memperhatikan beberapa hal yang penting seperti mengidentifikasi dan mengatasi hambatan, Mengembangkan kemampuan adaptasi tim untuk menghadapi perubahan, harus dapat menjaga motivasi seluruh tim untuk menciptakan perubahan, harus dapat mengukur dan mengevaluasi hasil perubahan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, implementasi kepemimpinan yang efektif dapat membantu menciptakan perubahan yang signifikan dalam organisasi.

Sistem kepemimpinan di lembaga kesehatan di Indonesia memiliki struktur dan proses untuk mengelola dan memimpin lembaga kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan lembaga kesehatan lainnya. Sistem kepemimpinan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepuasan pasien.

Komponen Sistem Kepemimpinan di Lembaga Kesehatan memiliki beberapa sistem yang terstruktur yang dimulai dari adanya struktur organisasi yang jelas dan efektif, dan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Pemimpin harus mampu membuat perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan berkomunikasi dengan baik dari segala arah. Pemimpin harus berasal dari sumber daya manusia yang berkualitas terlatih, dengan kemampuan memimpin yang efektif, model kepemimpinan yang berfokus pada transformasi dan perubahan, dengan fokus pada inspirasi dan motivasi sehingga kebijakan-kebiakan yang muncul dari sistem kesehatan mampu memberikan perubahan yang efisien dalam organisasi kesehatan, dengan demikian, sistem kepemimpinan di lembaga kesehatan adalah kunci untuk

meningkatkan kualitas layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepuasan pasien.

B. Hambatan dalam menjalankan inovasi dalam organisasi kesehatan

Ada banyak hambatan yang terjadi dalam menjalankan

inovasi dalam organisasi kesehatan diantaranya keterbatasan sumber daya, seperti dana, SDM, dan teknologi, dapat menghambat inovasi. Dalam survei yang dilakukan oleh World Health

Organization (WHO) pada tahun 2020, 75% responden menyatakan bahwa keterbatasan dana adalah hambatan terbesar bagi inovasi baru dalam organisasi kesehatan. Kultur organisasi yang tidak mendukung terjadinya inovasi, seperti ketakutan akan perubahan dan resistensi terhadap ide baru akan menghambat terjadinya inovasi dan perubahan, Kepemimpinan yang tidak efektif, faktor ini sangat besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu inovasi dan perubahan seperti kurangnya visi dan strategi dari pemimpin, pemimpin yang tidak paham birokrasi dan komunikasi dan koordinasi dapat menghambat inovasi. Kepemimpinan yang terlalu birokratis dapat menghambat inovasi karena proses pengambilan keputusan yang lambat dan terlalu banyak prosedur, ada juga kepemimpinan yang tidak mendukung inovasi contoh pemimpin yang tidak memberikan dukungan kepada tim. Inovasi juga akan sulit terlaksana apabila kepemimpinan yang terlalu fokus pada hasil kurang perhatian pada proses dan pengembangan ide-ide baru, komunikasi yang tidak baik terhadap tim tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dan teknologi baru, seperti contoh Seorang direktur rumah sakit yang tidak mau mendengar ide-ide dari tim dan bawahannya dan beranggapan inovasi teknologi telemedicine itu tidak perlu karena ia merasa bahwa konsultasi secara langsung lebih efektif. Hal ini menghambat inovasi dalam pengembangan layanan kesehatan jarak jauh. Di Rumah Sakit Cipto mangunkusumo, proses persetujuan etik untuk penelitian membutuhkan waktu 6 bulan, sehingga menghambat penelitian dan inovasi dalam layanan kesehatan, (Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia. (2020). Vol. 8, No. 1.).

Di Puskesmas Kecamatan Tebet, regulasi mengharuskan penggunaan kertas untuk semua dokumen, sehingga menghambat penggunaan teknologi digital dan inovasi dalam layanan kesehatan. (Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia. (2020). Vol. 16, No. 1)

Dalam contoh kasus di atas, kepemimpinan yang menghambat inovasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kemampuan, kurangnya sumber daya, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya inovasi. Penghambat inovasi juga bisa berupa keterbatasan dana tidak memiliki sumber daya finansial

yang cukup untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide baru. Keterbatasan SDM yang terampil dan berpengalaman dapat menghambat inovasi karena organisasi kesehatan tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide baru, inovasi juga akan sulit terlaksana apabila terjadi keterbatasan teknologi, keterbatasan seperti fasilitas dan peralatan, dapat menghambat inovasi karena organisasi kesehatan tidak memiliki sumber daya fisik yang cukup untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide baru.

Ketergantungan pada sumber daya eksternal, seperti donor atau pemerintah, dapat menghambat inovasi karena organisasi kesehatan tidak memiliki kontrol atas sumber daya yang diperlukan. Sebuah lembaga kesehatan ingin mengembangkan teknologi kesehatan yang baru, tetapi tidak memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi tersebut. Dalam kasus-kasus tersebut, sumber daya dapat menjadi hambatan bagi inovasi karena organisasi kesehatan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan.

Keterbatasan dana adalah salah satu hambatan terbesar bagi inovasi baru dalam organisasi kesehatan. Inovasi baru seringkali memerlukan investasi yang signifikan dalam teknologi, SDM, dan infrastruktur, SDM yang terampil dan berpengalaman adalah hambatan lain yang signifikan bagi inovasi baru dalam organisasi kesehatan. Inovasi baru seringkali memerlukan keahlian dan pengetahuan yang spesifik.

Keterbatasan teknologi adalah hambatan lain yang signifikan bagi inovasi baru dalam organisasi kesehatan. Inovasi baru seringkali memerlukan teknologi yang canggih dan mutakhir. Namun, jika harus memilih satu sumber daya yang paling menghambat inovasi baru, maka jawabannya adalah Dana,

C. Simpulan

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dibutuhkan inovasi dalam kesehatan yang memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan, sehingga menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu inovasi dalam layanan kesehatan dapat meningkatkan efisiensi organisasi kesehatan dengan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan. Inovasi dalam organisasi kesehatan dapat meningkatkan kepuasan pasien dengan menyediakan layanan yang lebih personal dan responsif. Inovasi dapat meningkatkan keselamatan pasien dengan mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kualitas perawatan. Inovasi dapat meningkatkan daya saing organisasi kesehatan dengan menyediakan layanan yang lebih inovatif dan

berkualitas. Inovasi dalam organisasi kesehatan ini dapat berupa pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, pengembangan proses yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, pengembangan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kualitas layanan, kolaborasi dan kemitraan dengan organisasi lain untuk meningkatkan inovasi dan kualitas layanan. Dengan demikian, inovasi sangat penting dalam organisasi kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, kepuasan pasien, keselamatan pasien, dan daya saing.

Inovasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan meningkatkan efisiensi organisasi kesehatan, sedangkan kepemimpinan yang efektif adalah kunci untuk mengimplementasikan inovasi dan perubahan dalam organisasi kesehatan. Diperlukan Birokrasi yang baik tidak kaku dan fleksibel untuk menjalankan inovasi tersebut. Kolaborasi dan kemitraan antara organisasi kesehatan, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan inovasi dan perubahan dalam organisasi kesehatan. Pengembangan sumber daya manusia adalah kunci untuk meningkatkan inovasi dan perubahan dalam organisasi kesehatan di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, inovasi dan kepemimpinan dalam perubahan organisasi kesehatan dapat diimplementasikan melalui,

pengembangan strategi inovasi yang jelas dan terarah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta Pengembangan kepemimpinan yang efektif untuk mengimplementasikan inovasi dan perubahan dalam organisasi kesehatan tersebut, diperlukan kolaborasi dan kemitraan antara organisasi kesehatan, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan inovasi dan perubahan dalam organisasi kesehatan.

Dengan demikian, inovasi dan kepemimpinan dalam perubahan organisasi kesehatan di Indonesia dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan meningkatkan efisiensi organisasi kesehatan.

D. Referensi

- 10 Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia. (2020). Vol. 16, No. 1.
- Arif, M. (2020). Inovasi dan Kepemimpinan dalam Perubahan Organisasi Kesehatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 16(1), 1-10.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2020). Laporan Penelitian Kesehatan 2020.
- Budi, S. (2020). Kepemimpinan dan Inovasi dalam Organisasi Kesehatan. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia, 8(1), 1-12.

Innovation in Health Care: A Guide for Health Care Professionals oleh World Health Organization (2020)

Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia. (2020)Vol. 8, No. 1.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan 2020.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Strategi Inovasi Kesehatan 2020-2024.

Kepemimpinan dan Inovasi dalam Organisasi Kesehatan oleh S. Budi (2020)

Nursalam, manajemen keperawatan.(2020) Penerbit salemba medika.

Strategi Inovasi Kesehatan 2020-2024 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

World Health Organization. (2020). Innovation in Health Care: A Guide for Health Care Professionals.

World Health Organization. (2020). World Health Report 2020.

PROFIL PENULIS



Ns. Akbar Suseno, M.Kep. lahir di Manna, Bengkulu Selatan pada tanggal 20 September 1982. Penulis menyelesaikan pendidikan Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Andalas tahun 2007 dan pendidikan S2 peminatan Keperawatan Jiwa dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2024. Penulis bertugas sebagai PNS di RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi. Penulis pernah bekerja sebagai tenaga dosen tidak tetap di Akademi Keperawatan Pemprov. Riau di Rengat, Indragiri Hulu, serta beberapa kampus lainnya.

PROFIL PENULIS



Nama Lengkap
(dengan gelar)

I Made Raka, S.ST, M.Kes

Jabatan
Fungsional

Laki - Laki
Lektor

N I P
NIDN

196804131989121001
4013046802

Tempat dan
Tanggal Lahir

Mengwi, 13 April 1968

E-mail

maderakamade@gmail.com

Nomor

082133594880

Telepon/HP

Alamat Kantor

Jalan Basuki Rachmat Km.11,5 Klasaman
Kelurahan Sorong Timur

Nomor

-

Telepon/Faks

Lulusan yang
Telah Dihasilkan

Diploma III dan Diploma IV Keperawatan

Mata Kuliah yang
Diampu

Evidence Based
Asuhan Kegawat Daruratan
Keperawatan Dasar
Asuhan Keperawatan Penyakit Tropis
Konsep Dasar Keperawatan (KDK)
Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)
Anti Korupsi
Praktek Klinik Keperawatan I & II

PENDIDIKAN

Nama Perguruan Tinggi

S-1

Universitas
Hasanudin
Makasar

S-2

Universitas
Diponogoro Semarang

S-3

Bidang Ilmu

D IV
Perawat
Pendidik

Magister Kesehatan

Tahun masuk – Lulus

2002

2010-2012

PROFIL PENULIS



drg Arnetty, M.Kes. Lahir di Kota Bukittinggi, Sumbar 24 Juli 1967 Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah tahun 1994 dan Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat pada FK Universitas Andalas Padang dan lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 sebagai Dokter Gigi Pegawai Tetap pada Puskesmas Kumani Sawahlunto Sijunjung pada tahun 1995. Pada tahun 1998 sebagai Dosen pada Universitas Baiturrahmah Padang. Sebagai Dokter Gigi di RS Bayangkara Padang Pada Tahun 1998. Saat ini penulis bekerja di Kemenkes Poltekkes Padang mengampu mata kuliah Histologi Anatomi Fisiologi, Mikrobiologi, Penyakit Gigi Dan Mulut, Farmakologi, Manajemen Mutu. Saat ini penulis juga aktif sebagai Pengurus Organisasi Profesi Dokter Gigi PDGI tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Kota. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: arnetty0724@gmail.com

Motto: "A Good Teacher Opens The Mind, But A Great Teacher Also Opens The Heart"



Dr. Muh. Abdurrouf, S.Kep, Ns. M.Kep Lahir di Demak, 05 Mei 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2002. Pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 sebagai dosen di Akper Islam Sultan Agung. Saat ini penulis bekerja di Universitas Islam Sultan Agung mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Dokumentasi Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan, Keperawatan syariah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku praktik manajemen keperawatan, publikasi di beberapa jurnal terindeks SINTA, dan SCOPUS, seminar keperawatan tingkat regional dan nasional. Penulis aktif di beberapa organisasi antara lain ; pengurus Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan, Sekretaris Wilayah Himpunan Perawat Manajer Indonesia Jawa Tengah, Pengurus Lembaga Kesehatan PWNu. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: abdurrouf@unissula.ac.id

PROFIL PENULIS



Ceria Febiana, S.Si., M.KM., MOS. lahir di Cilacap, 10 Februari 1986. Penulis menempuh pendidikan tinggi jenjang Sarjana (S1) pada Program Studi Biologi, Universitas Jenderal Soedirman, dan lulus pada tahun 2008. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Padjadjaran dan menyelesaikan studi pada tahun 2011.

Riwayat karier akademik penulis diawali sebagai dosen tetap pada salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bandung sejak tahun 2012 hingga 2022. Sejak tahun 2022 hingga saat ini, penulis berstatus sebagai dosen tetap pada Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Politeknik Al Islam Bandung, dengan bidang keahlian epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan manajemen mutu rumah sakit.

Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah dan buku, di antaranya *Siap Hadapi Era New Normal*, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*, dan *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. Selain itu, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan akademik seperti seminar, workshop, serta pengembangan kurikulum di bidang kesehatan masyarakat dan administrasi rumah sakit.

Motto: “Berilmu, Beretika, dan Berdampak bagi Kesehatan Masyarakat; Epidemiologi sebagai Dasar, Mutu sebagai Tujuan.”

PROFIL PENULIS



Ns. Siti Hotna siagian, S.Kep., M.Kep. lahir di Desa Alang Bombon, 11 Mei 1980.

Riwayat pekerjaan Sebagai dosen pengajar diFakultas ilmu keperawatan di Universitas Pahlawan Riau. Penulis menempuh Pendidikan D-3 Ilmu keperawatan Universitas Sumatera Utara Fakultas Kedokteran tahun 1998 , pada tahun 2005 penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan dan profesi Ners Fakultas ilmu Keperawatan Universitas Sumatera Utara Medan

dan saat itu masih bekerja menjadi dosen tetap di AKPER KESDAM I/ BB Binjai, dilanjutkan tahun 2013 penulis menyelesaikan S2 diUniversitas Andalas Sumatera Barat Padang, yang saat itu juga penulis sebagai dosen di AKBID PETRO MANDAU DURI dan STIKES PUTRA ABADI LANGKAT, Selain sebagai dosen, Saat ini penulis sebagai dosen tetap di Universitas Pahlawan Fakultas ilmu Kesehatan dalam program studi S1 keperawatan dan mengampu mata kuliah Asuhan keperawatan gerontik, dan manajemen keperawatan dan ilmu keperawatan paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar Kesehatan. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif dalam organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) Serta komitmen membuka homecare berupa Mam dan baby spa, dan pengobatan tibbun Nabawi hingga sekarang dikota Pekanbaru Riau Indonesia.

Sinopsis

Buku *Bunga Rampai Kebijakan, Manajemen, dan Sistem Kesehatan: Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia* menyajikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana kebijakan dan tata kelola sistem kesehatan memengaruhi mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta capaian kesehatan masyarakat. Bunga rampai ini menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh aspek klinis, tetapi juga oleh kekuatan sistem—pembiayaan, sumber daya, tata kelola, informasi kesehatan, dan kemampuan organisasi beradaptasi terhadap perubahan—sehingga diperlukan perspektif manajerial dan kebijakan yang terintegrasi.

Pembahasan diawali dengan kerangka sistem kesehatan dan arah kebijakan nasional. **Chapter 1** menganalisis sistem kesehatan Indonesia menggunakan kerangka *WHO Health System Building Blocks*, menguraikan enam komponen utama, tantangan yang dihadapi, serta gambaran implementasinya. **Chapter 2** membahas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan transformasi sistem kesehatan nasional, serta keterkaitannya dengan sistem kesehatan dan target SDGs bidang kesehatan tahun 2030. Selanjutnya, **Chapter 3** menyoroti manajemen pelayanan kesehatan primer melalui penguatan Puskesmas, penerapan *family medicine*, dan PIS-PK sebagai instrumen intervensi keluarga, termasuk strategi sinergi dan keberlanjutan program.

Pada bagian penguatan mutu dan inovasi, **Chapter 4** membahas peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan, mencakup konsep dasar, regulasi di Indonesia, strategi penguatan, serta peran manajemen dan kepemimpinan dalam menjamin mutu. **Chapter 5** mengangkat digitalisasi sistem kesehatan melalui rekam medis elektronik, telehealth, dan *big data health* sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis data dan modernisasi layanan. **Chapter 6** menutup dengan inovasi dan kepemimpinan dalam perubahan organisasi kesehatan, termasuk hambatan implementasi inovasi dan arah perbaikan. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, praktisi, pengelola layanan, dan pemangku kebijakan sebagai referensi untuk memahami, merancang, dan menguatkan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

Buku Bunga Rampai Kebijakan, Manajemen, dan Sistem Kesehatan: Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia menyajikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana kebijakan dan tata kelola sistem kesehatan memengaruhi mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta capaian kesehatan masyarakat. Bunga rampai ini menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh aspek klinis, tetapi juga oleh kekuatan sistem—pembiayaan, sumber daya, tata kelola, informasi kesehatan, dan kemampuan organisasi beradaptasi terhadap perubahan—sehingga diperlukan perspektif manajerial dan kebijakan yang terintegrasi.

Pembahasan diawali dengan kerangka sistem kesehatan dan arah kebijakan nasional. Chapter 1 menganalisis sistem kesehatan Indonesia menggunakan kerangka WHO Health System Building Blocks, menguraikan enam komponen utama, tantangan yang dihadapi, serta gambaran implementasinya. Chapter 2 membahas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan transformasi sistem kesehatan nasional, serta keterkaitannya dengan sistem kesehatan dan target SDGs bidang kesehatan tahun 2030. Selanjutnya, Chapter 3 menyoroti manajemen pelayanan kesehatan primer melalui penguatan Puskesmas, penerapan family medicine, dan PIS-PK sebagai instrumen intervensi keluarga, termasuk strategi sinergi dan keberlanjutan program.

Pada bagian penguatan mutu dan inovasi, Chapter 4 membahas peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan, mencakup konsep dasar, regulasi di Indonesia, strategi penguatan, serta peran manajemen dan kepemimpinan dalam menjamin mutu. Chapter 5 mengangkat digitalisasi sistem kesehatan melalui rekam medis elektronik, telehealth, dan big data health sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis data dan modernisasi layanan. Chapter 6 menutup dengan inovasi dan kepemimpinan dalam perubahan organisasi kesehatan, termasuk hambatan implementasi inovasi dan arah perbaikan. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, praktisi, pengelola layanan, dan pemangku kebijakan sebagai referensi untuk memahami, merancang, dan menguatkan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

ISBN 978-634-7556-78-3 (PDF)



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

